

JUDUL TA

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Pradipta Rafa Mahesa

NIM: 13522162



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Agustus 2026

JUDUL TA

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Pradipta Rafa Mahesa

NIM: 13522162

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2026

Pembimbing,

Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si

NIP. 118110072

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung bagian Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan khususnya Pasal 2.1 dan Pasal 2.2.

Bandung, 25 Agustus 2026

Pradipta Rafa Mahesa

NIM 13522162

ABSTRAK

Lorem ipsum dolor sit amet . Operator grafis dan tipografi mengetahui hal ini dengan baik, pada kenyataannya semua profesi yang berhubungan dengan alam semesta komunikasi memiliki hubungan yang stabil dengan kata-kata ini, tetapi apa itu? Lorem ipsum adalah teks dummy tanpa arti. Ini adalah urutan kata Latin yang, sebagaimana posisinya, tidak membentuk kalimat dengan pengertian yang utuh, tetapi memberikan kehidupan pada teks uji yang berguna untuk mengisi ruang-ruang yang selanjutnya akan ditempati dari teks ad hoc yang disusun oleh para profesional komunikasi.

Ini tentu saja yang paling terkenal teks placeholder bahkan jika ada versi berbeda yang dapat dibedakan dari urutan pengulangan kata-kata Latin. Lorem ipsum berisi tipografi yang lebih banyak digunakan, sebuah aspek yang memungkinkan Anda untuk memiliki gambaran umum tentang rendering teks dalam hal pilihan font dan d ukuran font. Jika mengacu pada Lorem ipsum, ekspresi yang digunakan berbeda, yaitu fill text , fiktif text , blind text atau placeholder text : singkatnya, artinya juga bisa nol, tetapi kegunaannya sangat jelas untuk bertahan selama berabad-abad dan menolak versi ironis dan modern yang datang dengan kedatangan web.

Kata kunci: Lorem, Ipsum, Lorem Ipsum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, laporan tugas akhir yang berjudul "Judul TA" dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan tingkat sarjana. Perlu diakui pengerjaan tugas akhir ini didukung oleh banyak pihak. Khususnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si, selaku dosen pembimbing atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta memberikan saran dalam pengerjaan tugas akhir.
2. Bapak Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T, Ph.D dan Dr. Agung Dewandaru, S.T., M.Sc., selaku dosen penguji atas segala masukan dan kritik yang telah diberikan terhadap tugas akhir penulis.
3. Dicky Prima Satya, S.T, M.T., Bapak Adi Mulyanto, S.T, M.T., Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D., dan Tricya Esterina Widagdo, ST., M.Sc. selaku dosen koordinator tim tugas akhir atas usahanya mengingatkan mahasiswa program studi Teknik Informatika untuk mengerjakan tugas akhirnya.
4. Seluruh dosen program studi Teknik Informatika ITB yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Keluarga penulis, terutama orang tua dan kakak penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta dukungan lainnya selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman dan rekan seperjuangan mahasiswa bimbingan Bapak Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si terutamanya Grup DecMed loh dek, yaitu Bagas dan Tazki, sebagai teman perjuangan selama pengembangan DecMed.
7. Sahabat-sahabat terdekat dari grup "Keluarga Acu", dan "mrt gym" yang te-

lah memberikan bantuan, semangat, serta menjadi tempat berdiskusi dalam menghadapi berbagai proses akademik maupun nonakademik selama menempuh pendidikan di Teknik Informatika ITB.

8. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan disini yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Penulis juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam laporan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan riset-riset kedepannya.

Bandung, 25 Agustus 2026

Pradipta Rafa Mahesa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Pembahasan	5
BAB II STUDI LITERATUR	6
II.1 Rekam Medis Elektronik	6
II.1.1 Definisi dan Regulasi RME di Indonesia	6
II.1.2 Kebutuhan Keamanan dan Akuntabilitas Data RME	7
II.2 Threat Modeling dengan STRIDE	8
II.2.1 Konsep dan Kategori STRIDE	8
II.2.2 Dekomposisi Sistem dan Data Flow Diagram dalam Threat Modeling	9
II.2.3 Pendekatan STRIDE-per-Interaction	10
II.2.4 Penurunan Kebutuhan Audit Event dari Analisis Ancaman ..	11
II.3 Kontrol Akses	12
II.3.1 Definisi dan Jenis Kontrol Akses	12
II.3.2 Keterkaitan Kontrol Akses dan Audit Trail dalam Tata Ke- lola Akses	13
II.4 Distributed Ledger Technology dan Immutability	14
II.4.1 DLT sebagai Basis Pencatatan Tidak Berubah	14
II.4.2 IOTA	14

II.5	Arsitektur Layanan Pendukung dalam Sistem Terdesentralisasi	15
II.5.1	Pola Layanan Terpisah dalam Arsitektur DecMed	15
II.5.2	Proxy Re-Encryption dan IPFS.....	16
II.6	Penelitian Terkait	17
BAB III	ANALISIS PERSOALAN DAN RANCANGAN SOLUSI.....	19
III.1	Analisis	19
III.1.1	Analisis Masalah	19
III.1.2	Analisis Ancaman DecMed.....	21
III.1.3	Analisis Kebutuhan Audit Event	37
III.1.4	Analisis Kebutuhan Sistem	48
III.2	Rancangan	58
III.2.1	Arsitektur Sistem Audit Trail.....	58
III.2.2	Mekanisme Pembangkitan dan Penerimaan Audit Event	59
III.2.3	Mekanisme Pembentukan dan Penyimpanan Audit Record ..	60
III.2.4	Mekanisme Rotasi, Pengarsipan, dan Publikasi Metadata	61
III.2.5	Pemenuhan Kebutuhan Sistem	62
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	65
IV.1	Lingkungan Implementasi	65
IV.2	Implementasi	66
IV.2.1	Implementasi Skema Tipe Data Audit	66
IV.2.2	Implementasi Audit Receiver.....	67
IV.2.3	Implementasi Audit Logger	68
IV.2.4	Implementasi Log Rotation dan Archival Worker	69
IV.2.5	Implementasi Integrasi ATS pada PRE Server.....	71
IV.2.6	Implementasi Verifikasi Integritas Audit Record	72
IV.3	Pengujian	73
IV.4	Pengujian	73
BAB V	PENUTUP.....	74
V.1	Kesimpulan.....	74
V.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh gambar pengujian

77

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Data Flow Diagram Sistem DecMed.....	30
Gambar A.1. Contoh gambar	77

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Kategori Ancaman STRIDE dan Properti Keamanan yang Di- langgar	9
Tabel II.2. Relevansi Kategori STRIDE per Tipe Interaksi.....	11
Tabel III.1. Dependensi Eksternal Sistem DecMed	23
Tabel III.2. Titik Masuk Sistem DecMed	24
Tabel III.3. Aset Sistem DecMed	27
Tabel III.4. Level Kepercayaan Sistem DecMed	29
Tabel III.5. Klasifikasi Ancaman Sistem DecMed	31
Tabel III.6. Pemetaan Ancaman ke Audit Event.....	37
Tabel III.7. Daftar Audit Event Hasil Identifikasi	40
Tabel III.8. Skema Umum Atribut Audit.....	42
Tabel III.9. Atribut Audit Tambahan untuk Setiap Audit Event.....	42
Tabel III.10. Analisis Gap Audit Event pada DecMed.....	45
Tabel III.11. Identifikasi Komponen Infrastruktur Audit Trail berdasarkan ISO 27789 Annex B	48
Tabel III.12. Analisis Gap Infrastruktur Audit Trail terhadap DecMed	50
Tabel III.13. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Audit Trail berdasarkan NIST SP 800-53 Rev. 5.....	53
Tabel III.14. Kebutuhan Fungsional Sistem Audit Trail	57
Tabel III.15. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Audit Trail	57
Tabel III.16. Atribut Umum Audit Event	60
Tabel III.17. Pemetaan Kebutuhan ke Mekanisme Rancangan ATS	62
Tabel IV.1. Dependensi Utama Audit Trail Service	65
Tabel IV.2. Daftar Implementasi Sistem Audit Trail	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk menyelenggarakan rekam medis dalam bentuk elektronik, serta mengharuskan penyelenggaraan tersebut menjamin kerahasiaan, keutuhan (integritas), dan ketersediaan data rekam medis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Tinjauan sistematis terhadap implementasi RME turut menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan data medis pasien menjadi perhatian utama dalam berbagai studi, mengingat data tersebut bersifat sensitif dan berdampak langsung pada kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan (Pramesti dkk., 2024). Kewajiban ini menegaskan bahwa keamanan data RME bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan juga kepatuhan regulasi yang mengikat bagi seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian sebelumnya mengembangkan DecMed, sebuah kerangka kerja manajemen RME terdesentralisasi yang menggunakan Distributed Ledger Technology (DLT) IOTA sebagai basis kontrol akses (Purnama dkk., 2026). DecMed mengintegrasikan Capability-Based Access Control (CapBAC), Proxy Re-Encryption (PRE), dan InterPlanetary File System (IPFS) (Benet, 2014) untuk memastikan bahwa setiap akses terhadap data RME hanya dapat dilakukan atas persetujuan aktif pasien, dengan durasi dan cakupan akses yang dapat dibatasi oleh pasien sendiri (Purnama dkk., 2026).

Meskipun DecMed berhasil menjawab persoalan kontrol akses dan kerahasiaan data, penelitian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan RME juga membutuhkan *audit trail* yang andal dan dapat diverifikasi (*reliable and verifiable audit trails*), karena pencatatan log merupakan komponen inti dari kontrol audit dan umumnya disyaratkan untuk mendukung kepatuhan regulasi maupun investigasi in-

siden (Purnama dkk., 2026). Klaim ini sejalan dengan kerangka kontrol audit pada NIST Special Publication 800-53 Revisi 5, yang menempatkan pencatatan dan peninjauan peristiwa keamanan (kontrol keluarga *Audit and Accountability*) sebagai salah satu persyaratan dasar tata kelola keamanan sistem informasi (National Institute of Standards and Technology, 2020), sejalan pula dengan kontrol *logging* pada ISO/IEC 27002:2022 (International Organization for Standardization, 2022). Catatan audit yang lengkap juga berperan penting sebagai sumber data untuk mendeteksi dan menyelidiki potensi penyalahgunaan oleh pihak internal (*insider threat*) (Theis dkk., 2022), serta menjadi prasyarat akuntabilitas pada mekanisme akses darurat (*break-glass access*) yang lazim dibutuhkan dalam layanan kesehatan (Al Amin dkk., 2025).

Namun demikian, mekanisme pencatatan yang tersedia pada DecMed saat ini belum sepenuhnya memenuhi karakteristik audit trail yang baik. Terdapat dua celah utama yang teridentifikasi. *Pertama*, sebagian besar mekanisme yang tercatat pada jaringan IOTA merupakan entri *capability* atau izin akses (*access grant*) – yaitu metadata yang menyatakan siapa berhak mengakses data apa dan sampai kapan – bukan catatan atas peristiwa akses yang benar-benar terjadi (*access event*). Akibatnya, sistem belum dapat merekonstruksi riwayat siapa yang benar-benar membaca atau mengubah data RME pada waktu tertentu. *Kedua*, sejumlah operasi pada DecMed, seperti pencabutan akses (*revoke_access*) dan pembaruan data administratif maupun klinis (*update_administrative_data*, *update_medical_record*), menyebabkan entri lama pada state tergantikan oleh entri baru alih-alih ditambahkan sebagai riwayat baru yang bersifat *append-only*. Kondisi ini bertentangan dengan karakteristik dasar audit trail, yaitu integritas dan *non-repudiation*, yang mensyaratkan bahwa setiap catatan peristiwa harus bersifat permanen dan tidak dapat diubah maupun dihapus setelah dicatat (National Institute of Standards and Technology, 2020).

Celah tersebut menjadi lebih krusial apabila ditinjau dari perspektif ancaman keamanan sistem. Metode STRIDE (*Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege*) merupakan salah satu metode pemodelan ancaman yang umum digunakan untuk mengidentifikasi risiko keamanan pada suatu sistem informasi secara sistematis, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan model DREAD (Laksono dan Prayudi, 2021). Salah satu kategori ancaman pada STRIDE, yaitu *repudiation*, merupakan

kondisi ketika pengguna sistem dapat menyangkal bahwa ia telah melakukan suatu tindakan tertentu; ancaman ini secara langsung berkaitan dengan ketiadaan atau ketidaklengkapan pencatatan log dan mekanisme audit pada suatu sistem (Laksono dan Prayudi, 2021). Dengan kata lain, kebutuhan pencatatan peristiwa (*event*) pada suatu sistem idealnya tidak ditentukan secara ad hoc, melainkan diturunkan dari analisis ancaman yang relevan terhadap arsitektur sistem yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Tugas Akhir ini bermaksud menganalisis kebutuhan audit trail pada sistem DecMed melalui pendekatan pemodelan ancaman STRIDE, guna menentukan jenis peristiwa (*event*) apa saja yang perlu dicatat agar sistem memiliki audit trail yang memenuhi karakteristik integritas dan non-repudiation. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perancangan dan implementasi sebuah layanan audit trail (*audit trail service*) yang terintegrasi dengan arsitektur DecMed yang telah ada, mengikuti pola layanan pendukung (*supporting service*) yang serupa dengan *proxy re-encryption server* yang sudah digunakan pada DecMed (Purnama dkk., 2026). Metadata dari setiap peristiwa yang tercatat akan disimpan pada jaringan IOTA untuk menjamin integritas dan keterlacakannya, sedangkan berkas log peristiwa akan disimpan pada IPFS (Benet, 2014), konsisten dengan pola pemisahan penyimpanan on-chain dan off-chain yang telah diterapkan pada DecMed untuk data RME (Purnama dkk., 2026).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada Subbab I.1, terdapat dua rumusan masalah utama dalam Tugas Akhir ini, yaitu

1. Peristiwa (*event*) apa saja yang perlu dicatat oleh mekanisme audit trail pada sistem DecMed?
2. Bagaimana rancangan dan implementasi layanan audit trail yang sesuai dengan arsitektur DecMed?

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah

1. Menghasilkan daftar kebutuhan peristiwa (*event requirements*) audit trail pada sistem DecMed berdasarkan analisis ancaman menggunakan metode STRIDE.
2. Merancang dan mengimplementasikan layanan audit trail yang terintegrasi dengan arsitektur DecMed.

Ukuran keberhasilan pencapaian Tugas Akhir ini didasarkan pada kesesuaian daftar kebutuhan *event* yang dihasilkan terhadap kategori ancaman STRIDE yang teridentifikasi, serta keberhasilan layanan audit trail yang dikembangkan dalam mencatat, menyimpan, dan menyajikan kembali peristiwa-peristiwa tersebut secara benar dan tidak dapat diubah (*immutable*).

I.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dari Tugas Akhir ini, antara lain

1. Analisis ancaman menggunakan STRIDE dilakukan terhadap arsitektur sistem DecMed yang sudah ada, bukan terhadap perancangan ulang sistem DecMed secara keseluruhan;
2. Layanan audit trail yang dikembangkan bersifat pencatat pasif (*passive recorder*) yang menerima dan menyimpan peristiwa, tanpa melakukan validasi otorisasi maupun keputusan kontrol akses terhadap peristiwa yang dicatat; dan
3. Implementasi dilakukan pada lingkungan pengembangan yang sama dengan yang digunakan pada penelitian DecMed sebelumnya.

I.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terdiri dari empat tahap pelaksanaan, sebagai berikut.

1. **Tahap Perencanaan.** Tahap ini berfokus pada pemahaman arsitektur dan mekanisme sistem DecMed yang telah ada, kajian literatur terkait audit trail, threat modeling STRIDE, serta penelitian terkait lainnya sebagai dasar analisis.

2. **Tahap Analisis Ancaman.** Pada tahap ini dilakukan identifikasi aset, aliran data, dan batas kepercayaan (*trust boundary*) pada arsitektur DecMed, dilanjutkan dengan penerapan metode STRIDE untuk mengidentifikasi ancaman pada setiap komponen. Hasil identifikasi ancaman tersebut kemudian diturunkan menjadi daftar kebutuhan peristiwa (*event requirements*) yang perlu dicatat oleh audit trail.
3. **Tahap Perancangan dan Implementasi.** Berdasarkan daftar kebutuhan *event* yang telah ditentukan, dilakukan perancangan arsitektur layanan audit trail beserta skema penyimpanan metadata pada IOTA dan berkas log pada IPFS. Selanjutnya, rancangan tersebut diimplementasikan sebagai layanan yang terintegrasi dengan komponen-komponen DecMed yang sudah ada.
4. **Tahap Pengujian dan Evaluasi.** Tahap terakhir bertujuan menguji dan mengevaluasi apakah layanan audit trail yang dikembangkan berhasil mencatat seluruh *event* yang telah didefinisikan, serta memvalidasi bahwa data yang tercatat memenuhi karakteristik integritas dan non-repudiation yang diharapkan.

I.6 Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan dari Tugas Akhir ini.

Bab I menjelaskan gagasan utama dari Tugas Akhir ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, metodologi, hingga sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan studi literatur yang dilakukan, mencakup RME, audit trail, threat modeling STRIDE, kontrol akses, DLT dan IOTA, serta teknologi pendukung lain yang digunakan pada DecMed.

Bab III menjelaskan analisis ancaman menggunakan STRIDE terhadap sistem DecMed serta rancangan solusi layanan audit trail yang diusulkan.

Bab IV menjelaskan hasil implementasi dari rancangan yang dipaparkan pada Bab III, beserta mekanisme dan hasil pengujian yang dilakukan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Rekam Medis Elektronik

II.1.1 Definisi dan Regulasi RME di Indonesia

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sedangkan Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan definisi tersebut, RME bukan sekadar bentuk digital dari berkas rekam medis konvensional, melainkan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan yang berkelanjutan, mulai dari bagaimana data dibuat, diakses, disimpan, hingga didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 juga mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia, mulai dari praktik mandiri tenaga kesehatan hingga rumah sakit, untuk menyelenggarakan RME sebagai pengganti rekam medis konvensional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Selain mewajibkan bentuk elektronik, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 turut mengatur hak pasien atas data rekam medis miliknya, termasuk larangan akses oleh pihak yang tidak berwenang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Ketentuan ini menjadi dasar regulasi bahwa setiap akses terhadap data RME seorang pasien pada dasarnya harus melalui mekanisme yang dapat mempertanggungjawabkan siapa yang mengakses, kapan, dan untuk keperluan apa. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengategorikan RME sebagai dokumen elektronik sehingga harus dibuat dan dikelola

dalam sistem elektronik dengan jaminan keamanan dan akuntabilitas agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Dengan kata lain, regulasi di Indonesia tidak hanya menuntut RME diselenggarakan secara elektronik, tetapi juga menuntut adanya mekanisme yang menjamin kerahasiaan dan keutuhan data tersebut sepanjang siklus penyelenggaraannya, sebuah kebutuhan yang menjadi dasar bagi berbagai penelitian pengembangan sistem manajemen RME yang berfokus pada keamanan data, salah satunya DecMed (Purnama dkk., 2026).

II.1.2 Kebutuhan Keamanan dan Akuntabilitas Data RME

Data RME tergolong sebagai data yang sensitif karena memuat informasi identitas dan kondisi kesehatan pasien, sehingga keamanan dan kerahasiaannya menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian sistem informasi kesehatan. Tinjauan sistematis terhadap implementasi RME menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kerahasiaan data medis pasien secara konsisten menjadi isu sentral, dan kegagalan menjaga aspek tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan yang digunakan (Pramesti dkk., 2024). Kerahasiaan data RME tidak dapat dijaga hanya dengan membatasi siapa saja yang boleh mengakses data (kontrol akses), tetapi juga membutuhkan mekanisme yang dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut benar-benar dipatuhi dan dapat ditelusuri kembali ketika terjadi insiden.

Kebutuhan penelusuran kembali (*traceability*) inilah yang menjadikan akuntabilitas sebagai aspek keamanan yang tidak dapat dipisahkan dari kerahasiaan dan integritas data RME. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk menghubungkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap data dengan identitas pihak yang melakukannya, sehingga setiap pihak yang mengakses maupun mengubah data RME dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sebagai contoh, kerangka kerja DecMed yang menjadi basis pengembangan pada Tugas Akhir ini dirancang agar seluruh akses terhadap data RME hanya dapat dilakukan atas persetujuan aktif pasien melalui mekanisme kontrol akses berbasis *capability* (Purnama dkk., 2026). Namun demikian, tanpa mekanisme yang menjamin akuntabilitas, kontrol akses yang ketat sekalipun tidak dapat membuktikan bahwa suatu pelanggaran keamanan benar-benar terjadi, siapa pihak yang bertanggung jawab,

maupun bagaimana kronologi pelanggaran tersebut (Purnama dkk., 2026). Kebutuhan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya mekanisme audit trail sebagai pelengkap dari kontrol akses pada sistem manajemen RME, yang akan dibahas lebih lanjut pada Subbab ??.

II.2 Threat Modeling dengan STRIDE

II.2.1 Konsep dan Kategori STRIDE

Threat modeling (pemodelan ancaman) merupakan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengenumerasi, dan memprioritaskan ancaman keamanan pada suatu sistem sebelum ancaman tersebut benar-benar dieksploitasi (**shostack2014**). Proses ini umumnya terdiri atas empat pertanyaan pokok: apa yang sedang dibangun, apa yang dapat salah, apa yang perlu dilakukan terhadap hal tersebut, dan apakah pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan cukup baik (**shostack2014**).

STRIDE merupakan salah satu kerangka kerja *threat modeling* yang dikembangkan oleh Loren Kohnfelder dan Praerit Garg di Microsoft, dengan nama yang dibentuk dari huruf pertama masing-masing kategori ancaman (**shostack2014**). Kerangka kerja ini dirancang untuk membantu pengembang perangkat lunak mengidentifikasi jenis-jenis serangan yang cenderung dialami suatu sistem. Setiap kategori STRIDE merupakan kebalikan dari properti keamanan yang diinginkan pada suatu sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.1.

Kategori *Repudiation* memiliki karakteristik yang berbeda dari kategori lainnya: ancaman ini beroperasi pada lapisan bisnis, bukan semata pada lapisan teknis jaringan atau aplikasi (**shostack2014**). Penting untuk dipahami bahwa repudiasi tidak selalu merupakan tindakan jahat — seseorang dapat secara jujur menyatakan tidak melakukan sesuatu karena kegagalan teknologi atau proses. Oleh karena itu, pertanyaan kunci bagi perancang sistem adalah: *bukti apa yang dimiliki sistem untuk membantah atau membuktikan suatu klaim?* Apabila sistem tidak memiliki log, tidak menyimpan log, atau tidak dapat menganalisis log, ancaman repudiasi menjadi sangat sulit untuk dibantah (**shostack2014**). Hal ini menegaskan keterkaitan langsung antara kategori *Repudiation* pada STRIDE dengan kebutuhan mekanisme audit trail pada suatu sistem.

Tabel II.1: Kategori Ancaman STRIDE dan Properti Keamanan yang Dilanggar

Kategori	Properti yang Dilanggar	Definisi
Spoofing	Authentication	Berpura-pura menjadi sesuatu atau seseorang selain diri sendiri.
Tampering	Integrity	Memodifikasi sesuatu pada disk, jaringan, atau memori.
Repudiation	Non-repudiation	Mengklaim tidak melakukan sesuatu atau tidak bertanggung jawab atas suatu tindakan.
Information Disclosure	Confidentiality	Memberikan informasi kepada pihak yang tidak berwenang untuk melihatnya.
Denial of Service	Availability	Menyerap sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan.
Elevation of Privilege	Authorization	Memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diizinkan untuk dilakukan.

II.2.2 Dekomposisi Sistem dan Data Flow Diagram dalam Threat Modeling

Sebelum mengidentifikasi ancaman menggunakan STRIDE, suatu sistem perlu didekomposisi terlebih dahulu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai cara kerja sistem dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas eksternal (**shostack2014**). Dekomposisi ini umumnya mencakup identifikasi deskripsi sistem, dependensi eksternal, titik masuk (*entry points*), aset yang perlu dilindungi, dan tingkat kepercayaan (*trust level*) dari setiap entitas yang terlibat.

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat utama yang digunakan dalam tahap dekomposisi ini. DFD menggambarkan bagaimana data mengalir di antara elemen-elemen sistem, sehingga memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi di mana ancaman keamanan paling mungkin muncul (**shostack2014**). DFD dalam konteks *threat modeling* terdiri atas empat elemen dasar:

- **Proses** (*process*) – elemen yang menerima, mengolah, dan mengirimkan data; direpresentasikan sebagai lingkaran atau persegi panjang dengan sudut membulat.
- **Penyimpanan data** (*data store*) – tempat data disimpan secara persisten; direpresentasikan sebagai dua garis paralel.
- **Aliran data** (*data flow*) – perpindahan data antar elemen; direpresentasikan

sebagai panah berlabel.

- **Entitas eksternal** (*external entity*) – aktor atau sistem di luar kendali sistem yang dianalisis; direpresentasikan sebagai persegi panjang.

Elemen tambahan yang krusial dalam *threat modeling* adalah **batas kepercayaan** (*trust boundary*), yang memisahkan bagian-bagian sistem dengan tingkat kepercayaan berbeda dan direpresentasikan sebagai garis putus-putus. Ancaman paling signifikan umumnya muncul pada aliran data yang melintasi batas kepercayaan ini, karena pada titik itulah asumsi mengenai kepercayaan terhadap data maupun pengirimnya berubah (**shostack2014**).

II.2.3 Pendekatan STRIDE-per-Interaction

Terdapat dua pendekatan utama dalam menerapkan STRIDE pada DFD suatu sistem: STRIDE-per-element dan STRIDE-per-interaction (**shostack2014**).

STRIDE-per-element merupakan pendekatan yang lebih sederhana, di mana setiap elemen DFD (proses, penyimpanan data, aliran data, entitas eksternal) diperiksa terhadap subset kategori STRIDE yang paling relevan bagi tipe elemen tersebut. Pendekatan ini mudah dipelajari dan dapat digunakan tanpa memerlukan tabel referensi yang kompleks, namun cenderung menghasilkan ancaman yang serupa berulang kali pada model yang besar (**shostack2014**).

STRIDE-per-interaction merupakan pendekatan yang lebih rinci, di mana ancaman diperiksa berdasarkan setiap interaksi antar elemen dalam bentuk tuple (asal, tujuan, jenis interaksi), bukan berdasarkan elemen secara individual (**shostack2014**). Pendekatan ini dikembangkan oleh Larry Osterman dan Douglas MacIver di Microsoft. Keunggulan utamanya adalah bahwa ancaman diidentifikasi dalam konteks interaksi nyata yang terjadi pada sistem, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih langsung terhubung ke keputusan perancangan yang perlu diambil (**shostack2014**).

Pada STRIDE-per-interaction, tidak semua kategori STRIDE relevan untuk setiap tipe interaksi. Tabel II.2 menunjukkan kategori STRIDE yang relevan untuk setiap tipe interaksi berdasarkan kerangka yang dikembangkan oleh Shostack (**shostack2014**).

Sebagai ilustrasi penerapan tabel tersebut: ketika sebuah proses menerima *input* dari entitas eksternal, ancaman yang relevan adalah *Spoofing* (entitas eksternal yang

Tabel II.2: Relevansi Kategori STRIDE per Tipe Interaksi

Tipe Interaksi	S	T	R	I	D	E
Proses mengirim output ke proses lain	✓	✓	✓	✓		✓
Proses mengirim output ke entitas eksternal (kode)	✓		✓	✓		
Proses mengirim output ke entitas eksternal (manusia)			✓			
Proses menerima input dari penyimpanan data	✓	✓	✓	✓		
Proses menerima input dari proses lain	✓		✓		✓	✓
Proses menerima input dari entitas eksternal	✓		✓		✓	✓
Proses mengirim output ke penyimpanan data		✓	✓	✓	✓	
Aliran data melintasi batas mesin/jaringan	✓	✓		✓	✓	
Penyimpanan data menerima aliran data dari proses		✓	✓	✓	✓	
Penyimpanan data mengirim aliran data ke proses		✓	✓	✓	✓	
Entitas eksternal mengirim input ke proses	✓		✓	✓		
Entitas eksternal menerima input dari proses	✓		✓			

mengirim data mungkin bukan entitas yang sebenarnya), *Repudiation* (entitas eksternal dapat menyangkal pernah mengirimkan data tersebut), dan *Elevation of Privilege* (entitas eksternal dapat mengirim data yang memaksa proses melakukan sesuatu di luar kewenangan pengirim). Sebaliknya, *Tampering* dan *Denial of Service* kurang relevan pada interaksi ini karena proses yang menerima data umumnya sudah memiliki kendali penuh atas cara data tersebut diproses (shostack2014).

STRIDE-per-interaction memerlukan tabel referensi untuk digunakan secara efektif, namun menghasilkan ancaman yang lebih kontekstual dan lebih mudah dihubungkan ke keputusan mitigasi yang spesifik (shostack2014).

II.2.4 Penurunan Kebutuhan Audit Event dari Analisis Ancaman

Hasil klasifikasi ancaman menggunakan STRIDE pada suatu sistem selanjutnya dapat dinilai tingkat risikonya menggunakan metodologi DREAD (*Damage potential*,

Reproducibility, Exploitability, Affected user, Discoverability), sehingga dapat disusun peringkat ancaman yang menjadi dasar prioritas penyusunan langkah mitigasi (Laksono dan Prayudi, 2021). Setiap kategori ancaman STRIDE pada dasarnya berkaitan dengan bidang keamanan (*security control*) tertentu yang relevan sebagai acuan mitigasinya, misalnya kategori *Spoofing* berkaitan dengan bidang *authentication*, kategori *Tampering* berkaitan dengan bidang *integrity*, dan kategori *Repudiation* berkaitan dengan bidang *non-repudiation* (Laksono dan Prayudi, 2021).

Penerapan STRIDE pada studi kasus sistem informasi akademik menunjukkan keterkaitan langsung antara ancaman kategori *Repudiation* dengan kebutuhan pencatatan log. Salah satu ancaman kategori *Repudiation* yang teridentifikasi pada studi tersebut adalah pencatatan log yang minim sebagai bukti penanganan klaim penyangkalan (Laksono dan Prayudi, 2021). Langkah mitigasi yang diusulkan untuk ancaman kategori *Repudiation* pada studi tersebut mencakup ketentuan bahwa segala tindakan yang dilakukan pada sistem harus dicatat pada log sebagai bahan pembuktian atas terjadinya suatu tindakan, disertai penerapan tanda tangan digital (*digital signature*) yang tercatat secara otomatis pada log setiap kali terjadi perubahan data (Laksono dan Prayudi, 2021).

II.3 Kontrol Akses

II.3.1 Definisi dan Jenis Kontrol Akses

Kontrol akses merupakan mekanisme yang bertujuan membatasi tindakan atau operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna sah dalam suatu sistem komputer, termasuk mengatur tindakan dari program yang berjalan atas nama pengguna tersebut. Terdapat beberapa model kontrol akses yang umum digunakan, di antaranya Role-Based Access Control (RBAC), yang mengatur akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimilikinya, dan Attribute-Based Access Control (ABAC), yang mengatur akses dengan menilai atribut yang melekat pada subjek, objek, serta kondisi lingkungan yang relevan (Purnama dkk., 2026).

Model kontrol akses lain yang relevan dengan Tugas Akhir ini adalah Capability-Based Access Control (CapBAC). Konsep utama CapBAC adalah *capability*, yaitu suatu objek yang berisi hak akses dan dapat diberikan kepada suatu entitas sehing-

ga entitas tersebut dapat mengakses data milik entitas lain (Hernández-Ramos dkk., 2013). Setiap entitas pemilik data dapat membuat capability dan mendistribusikannya secara langsung kepada penerima yang dituju, maupun menyimpannya pada suatu lokasi yang menjamin integritasnya (Purnama dkk., 2026). CapBAC menawarkan kontrol akses dengan granularitas tinggi, karena setiap capability dapat memuat berbagai atribut akses seperti metadata pemberi akses, bagian data yang dapat diakses, jenis akses, dan waktu kedaluwarsa akses, serta cocok digunakan pada lingkungan terdesentralisasi karena tidak membutuhkan otoritas terpusat untuk memvalidasi maupun memberikan akses (Purnama dkk., 2026).

II.3.2 Keterkaitan Kontrol Akses dan Audit Trail dalam Tata Kelola Akses

Kontrol akses dan audit trail merupakan dua mekanisme yang berbeda secara konseptual namun saling melengkapi dalam tata kelola akses terhadap suatu sistem. Otorisasi (*authorization*) didefinisikan sebagai pemberian hak, termasuk pemberian akses berdasarkan hak akses (*access rights*) yang dimiliki (International Organization for Standardization, 2021), sedangkan audit trail – sebagaimana telah dibahas pada Subbab ?? – merupakan rekaman kronologis atas aktivitas yang benar-benar terjadi pada sistem. Kedua konsep tersebut saling terhubung melalui kebijakan akses (*access policy*), yaitu bahwa audit trail dari suatu rekam medis elektronik disyaratkan untuk dapat mendukung kesesuaian terhadap etika profesi, kebijakan organisasi, dan regulasi yang berlaku, meskipun audit trail semata tidak cukup untuk menilai kelengkapan suatu rekam medis elektronik (International Organization for Standardization, 2021).

Keterkaitan antara kontrol akses dan audit trail juga tercermin pada tingkat akses terhadap audit trail itu sendiri. Akses terhadap audit trail disyaratkan untuk diatur oleh suatu kebijakan akses tersendiri, yang ditetapkan oleh organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan audit log (International Organization for Standardization, 2021). Standar yang sama turut mendefinisikan bidang *Participant Object Permission PolicySet* pada format audit record, yang berfungsi untuk merujuk kebijakan akses aktual yang berlaku pada suatu peristiwa (International Organization for Standardization, 2021), yang menunjukkan bahwa kebijakan kontrol akses dan catatan audit trail pada praktiknya perlu saling terhubung dan tidak dirancang sebagai

dua mekanisme yang terpisah sepenuhnya.

II.4 Distributed Ledger Technology dan Immutability

II.4.1 DLT sebagai Basis Pencatatan Tidak Berubah

Distributed Ledger Technology (DLT) merupakan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan data direkam dan disimpan pada sejumlah *node* dalam suatu jaringan, sehingga seluruh salinan *ledger* tetap tersinkronisasi dan konsisten satu sama lain (Purnama dkk., 2026). Karakteristik desentralisasi ini menghilangkan kebutuhan akan otoritas terpusat, sehingga meningkatkan transparansi dalam sistem, dan menjadikan DLT banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk keuangan, *supply chain*, kesehatan, dan energi (Purnama dkk., 2026).

Salah satu karakteristik utama DLT yang relevan bagi kebutuhan audit trail adalah *immutability*, yaitu sifat data yang telah tersimpan pada *ledger* tidak dapat diubah maupun dihapus setelah tercatat. Karakteristik ini menjadikan DLT sebagai salah satu teknologi yang cocok untuk diintegrasikan dengan mekanisme kontrol akses berbasis *capability* (CapBAC), karena DLT dapat berfungsi sebagai media penyimpanan bagi *capability* yang membutuhkan jaminan integritas (Purnama dkk., 2026).

II.4.2 IOTA

IOTA merupakan salah satu jenis DLT yang mengadopsi struktur jaringan berbasis *Directed Acyclic Graph* (DAG). Struktur jaringan DAG memungkinkan IOTA mendukung *throughput* yang tinggi, karena mampu memvalidasi transaksi baru secara lebih cepat dibandingkan *blockchain* konvensional seperti Bitcoin maupun Ethereum (Purnama dkk., 2026). Pada versi awalnya (IOTA 2.0), IOTA tidak membebankan biaya transaksi (*zero-cost transactions*), sehingga cocok digunakan untuk transaksi mikro maupun pada lingkungan ringan seperti perangkat Internet of Things (IoT). Namun, pada IOTA Rebased, model transaksi tanpa biaya tersebut tidak lagi berlaku, dan setiap transaksi dikenakan biaya (*gas fee*) (Purnama dkk., 2026).

IOTA Rebased menandai evolusi signifikan dari protokol IOTA, bertransisi dari

struktur Tangle yang mendukung transaksi tanpa biaya dan bergantung pada *co-ordinator* terpusat, menuju *object-based ledger* yang dibangun di atas DAG. Berbeda dari IOTA 2.0 yang berbasis model *Unspent Transaction Output* (UTXO), IOTA Rebased mengadopsi DAG berbasis objek yang terinspirasi dari arsitektur Sui Network, sehingga memungkinkan pemrosesan transaksi secara paralel dan mendukung pola transaksi yang kompleks melalui kontrol akses *fine-grained* (Purnama dkk., 2026). *Ledger* pada IOTA Rebased membedakan antara *shared objects*, yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh banyak entitas berdasarkan aturan yang telah ditentukan, dengan *owned objects*, yang sepenuhnya dikontrol oleh satu entitas (Purnama dkk., 2026). Konsensus pada IOTA Rebased ditenagai oleh protokol Mysticeti, sebuah sistem *Byzantine Fault Tolerant* (BFT) yang mengimplementasikan *Delegated Proof-of-Stake* (DPoS) untuk mencapai *throughput* tinggi dan *latency* rendah, dengan *finality* dalam waktu sekitar 500 milidetik dan mendukung lebih dari 50.000 transaksi per detik (Purnama dkk., 2026).

Untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan jaringan IOTA, tersedia IOTA Gas Station yang memungkinkan transaksi bersponsor (*sponsored transactions*), sehingga pengguna tidak perlu mengelola *token* untuk membayar biaya transaksi (Purnama dkk., 2026). Arsitektur IOTA Gas Station terdiri atas tiga komponen, yaitu Gas Station Server sebagai komponen utama yang menyediakan API untuk mereservasi *gas object* dan mengeksekusi transaksi, Gas Station Storage sebagai penyimpanan persisten untuk *gas object* dan status transaksi bersponsor, serta Key Store Manager (KSM) yang mengelola kunci untuk menandatangani transaksi, baik melalui layanan eksternal (*External Key Management Service*) maupun penyimpanan kunci dalam memori (Purnama dkk., 2026).

II.5 Arsitektur Layanan Pendukung dalam Sistem Terdesentralisasi

II.5.1 Pola Layanan Terpisah dalam Arsitektur DecMed

Arsitektur DecMed dirancang mengikuti pola tiga lapis (*three-tier architecture*), yang terdiri atas *Client Layer*, *Proxy Layer*, dan *Storage Layer* (Purnama dkk., 2026). *Client Layer* berfungsi sebagai antarmuka utama bagi seluruh aktor untuk

berinteraksi dengan sistem, dengan tiga aplikasi klien berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peran. *Proxy Layer* berperan sebagai *middleware* keamanan yang menegakkan kebijakan kontrol akses dan mengelola operasi kriptografi seperti Proxy Re-Encryption (PRE), sedangkan *Storage Layer* terbagi menjadi penyimpanan *on-chain* yang menjamin keutuhan *capability* akses, dan penyimpanan *off-chain* yang menangani data klinis terenkripsi dalam volume besar (Purnama dkk., 2026).

Lapisan *Proxy* dan *Storage* pada DecMed diimplementasikan melalui beberapa layanan (*server*) yang terpisah satu sama lain, masing-masing dengan tanggung jawab yang spesifik. Layanan *PRE Server* bertanggung jawab menangani proses *re-encryption*, di mana setiap kali menerima permintaan data, *server* tersebut terlebih dahulu memverifikasi entri *capability* pada jaringan IOTA sebelum melakukan *re-encryption* terhadap data yang diambil dari IPFS untuk pemohon, dengan Redis digunakan untuk menyimpan data sementara seperti *nonce* guna mencegah *replay attack* (Purnama dkk., 2026). Layanan *Gas Station Server* bertanggung jawab mensponsori transaksi pada jaringan IOTA, sehingga aktor yang tidak memiliki kepentingan finansial dapat berinteraksi dengan *ledger* tanpa perlu memiliki *token* (Purnama dkk., 2026). Kedua layanan tersebut berkomunikasi dengan jaringan IOTA maupun IPFS sesuai kebutuhannya masing-masing, sementara lapisan penyimpanan sendiri terbagi menjadi IOTA Tangle sebagai *trust anchor* yang immutable untuk kebijakan kontrol akses (CapBAC), dan IPFS Cluster sebagai penyimpanan *content-addressable* yang terdesentralisasi untuk berkas RME terenkripsi (Purnama dkk., 2026).

II.5.2 Proxy Re-Encryption dan IPFS

Proxy Re-Encryption (PRE) memanfaatkan *proxy* yang bersifat *semi-trusted* untuk mentransformasikan suatu *ciphertext* menjadi *ciphertext* baru yang isinya tetap sama, namun hanya dapat didekripsi menggunakan *secret key* milik subjek yang dituju (Purnama dkk., 2026). *Ciphertext* awal dihasilkan dari enkripsi data menggunakan *public key* milik *delegator* (pemilik data), dan dapat disimpan pada suatu lokasi penyimpanan seperti *cloud storage* maupun sistem DLT. Ketika *delegatee* (penerima akses) meminta akses terhadap data terenkripsi tersebut, *delegator* membuat *re-encryption key* menggunakan *secret key* miliknya dan *public key* mi-

lik *delegatee*; *re-encryption key* tersebut dikirimkan kepada *proxy*, yang kemudian menggunakannya bersama *ciphertext* awal dan *public key* kedua belah pihak untuk menghasilkan *ciphertext* baru yang hanya dapat didekripsi oleh *delegatee* (Purnama dkk., 2026). Meskipun PRE membatasi kemampuan *proxy* untuk mengetahui isi data asli (*plaintext*), arsitektur ini tetap memusatkan fungsi *re-encryption* pada satu entitas *semi-trusted*, sehingga menciptakan *single point of failure*: apabila *proxy* mengalami gangguan atau menjadi target serangan *denial-of-service*, seluruh proses *re-encryption* akan terhenti dan alur otorisasi maupun distribusi kunci menjadi tidak tersedia bagi seluruh subjek yang bergantung padanya (Purnama dkk., 2026).

InterPlanetary File System (IPFS) adalah suatu sistem berkas terdistribusi *peer-to-peer* yang bertujuan menghubungkan seluruh perangkat komputasi ke dalam satu sistem berkas (Benet, 2014). Berbeda dengan protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) konvensional yang menggunakan pengalamatan berbasis lokasi (*location-based addressing*), IPFS menggunakan pengalamatan berbasis konten (*content-based addressing*), yaitu data diidentifikasi dan diambil berdasarkan *hash* kriptografisnya yang disebut *Content Identifier* (CID) (Purnama dkk., 2026). Ketika suatu berkas ditambahkan ke jaringan IPFS, berkas tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, di-*hash* secara kriptografis, dan diberikan CID yang unik sebagai penanda permanen dan *immutable* dari data tersebut; apabila isi berkas berubah, *hash* kriptografisnya turut berubah dan menghasilkan CID yang sepenuhnya baru, sehingga karakteristik *immutability* ini menjadikan IPFS sangat kompatibel dengan DLT dalam menjaga integritas data (Purnama dkk., 2026). Dalam konteks penyimpanan data kesehatan, IPFS memungkinkan penyimpanan *off-chain* untuk berkas medis terenkripsi berukuran besar, sementara hanya CID berukuran kecil yang perlu disimpan pada *ledger* yang *immutable* (*on-chain*), sehingga mengatasi keterbatasan ukuran penyimpanan yang umum ditemukan pada jaringan DLT maupun *blockchain* tanpa mengorbankan arsitektur terdesentralisasi yang bebas dari *single point of failure* (Purnama dkk., 2026).

II.6 Penelitian Terkait

DecMed, sebagai kerangka kerja manajemen RME yang menjadi basis pengembangan Tugas Akhir ini, mengklaim menghasilkan mekanisme kontrol akses yang

didukung oleh audit trail yang tahan terhadap perusakan (*tamper-evident audit trails*) (Purnama dkk., 2026). Klaim tersebut didasarkan pada mekanisme bahwa setiap akses yang diberikan oleh pasien dicatat sebagai entri *capability* pada penyimpanan *on-chain* di jaringan IOTA, dan sifat *immutability* dari penyimpanan *on-chain* tersebut menjamin bahwa entri tidak dapat diubah oleh pihak lain, dengan setiap permintaan akses divalidasi terhadap keberadaan entri yang bersesuaian melalui *smart contract* (Purnama dkk., 2026). Peristiwa akses, pemberian persetujuan (*consent*), dan pelanggaran kebijakan pada DecMed dinyatakan tercatat secara *tamper-evident*, sehingga menyediakan audit trail yang dapat diandalkan untuk mendukung akuntabilitas lintas batas organisasi (Purnama dkk., 2026).

Salah satu contoh sistem audit trail yang secara khusus dibangun dengan memanfaatkan kombinasi DLT dan IPFS adalah LogStamping (Islam dan Rahman, 2025). Sistem tersebut menggunakan Ethereum sebagai platform *blockchain* dengan konsensus *Proof of Authority*, di mana log dikelompokkan menjadi beberapa *chunk* berdasarkan jumlah baris maupun interval waktu, kemudian dihitung *hash* SHA-256 dari setiap *chunk* tersebut dan disimpan pada *blockchain*, sementara berkas log asli yang telah terenkripsi dan terverifikasi diarsipkan secara terpisah pada IPFS untuk menjamin keberadaannya secara *tamper-proof* dan persisten (Islam dan Rahman, 2025). Pendekatan tersebut menghasilkan audit trail yang ringan (*lightweight*) dan dapat diverifikasi, karena *blockchain* hanya menyimpan *hash* sebagai bukti integritas alih-alih menyimpan seluruh data log secara langsung, sedangkan mekanisme verifikasi bekerja dengan menghitung ulang *hash* dari suatu kelompok log dan membandingkannya dengan *hash* yang tersimpan pada *blockchain* untuk mendeteksi adanya perubahan (Islam dan Rahman, 2025). Hasil pengujian pada sistem tersebut menunjukkan tingkat deteksi perusakan (*tamper detection*) sebesar 100% terhadap simulasi injeksi log palsu, serta pengurangan kebutuhan penyimpanan hingga 92% dibandingkan penyimpanan log mentah secara langsung pada *blockchain* (Islam dan Rahman, 2025).

BAB III

ANALISIS PERSOALAN DAN RANCANGAN SOLUSI

III.1 Analisis

III.1.1 Analisis Masalah

III.1.1.1 Analisis Sistem DecMed

Sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.6, DecMed adalah kerangka kerja manajemen RME terdesentralisasi dengan menggunakan DLT IOTA sebagai penyimpanan on-chain, IPFS sebagai penyimpanan off-chain, serta PRE untuk mendukung distribusi akses data yang aman Purnama dkk., 2026. Arsitektur ini sudah memberikan fondasi untuk menjaga integritas data dan mengurangi ketergantungan pada penyimpanan terpusat, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab II.4.1, II.4.2, dan II.5.1.

Meskipun arsitektur tersebut telah berhasil meningkatkan aspek keamanan penyimpanan data, DecMed lebih berfokus pada pencegahan serangan dan perlindungan data melalui kontrol akses. Aspek audit trail sebagai mekanisme untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengelola bukti digital selama proses investigasi insiden keamanan masih belum menjadi fokus pembahasan, sebagaimana ditunjukkan pada Subbab II.6, di mana DecMed baru mengklaim ketersediaan audit trail secara umum tanpa merinci komponen-komponen audit trail yang telah diuraikan pada Subbab ??.

Implementasi DecMed telah menyediakan beberapa bentuk pencatatan aktivitas sistem, yaitu *PatientAccessLog* dan *transaction block* pada jaringan IOTA. Kedua komponen tersebut telah mendokumentasikan sebagian aktivitas yang terjadi selama sistem beroperasi. Meskipun demikian, keduanya belum membentuk sebuah sistem *audit trail* yang mampu memenuhi kebutuhan audit maupun investigasi insiden keamanan, apabila dinilai terhadap karakteristik audit trail yang baik pada

Subbab ??.

PatientAccessLog digunakan untuk mencatat aktivitas pemberian hak akses dari pasien kepada tenaga medis. Informasi yang tersimpan telah mencakup atribut penting seperti identitas pasien, identitas tenaga medis, waktu pemberian akses (*timestamp*), serta informasi lain yang berkaitan dengan hak akses tersebut. Dengan demikian, aktivitas pemberian hak akses telah terdokumentasi secara cukup rinci.

Namun demikian, *PatientAccessLog* masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan aktivitas yang dicatat masih terbatas pada proses pemberian hak akses sehingga berbagai aktivitas lain yang memiliki nilai audit tinggi, seperti autentikasi, otorisasi, perubahan konfigurasi, maupun interaksi terhadap data rekam medis, belum terdokumentasi. Kondisi ini bertentangan dengan cakupan minimal peristiwa pemicu (*trigger events*) yang telah diuraikan pada Subbab ??, yaitu peristiwa akses (*access events*) dan peristiwa kueri (*query events*) terhadap data kesehatan pribadi. Kedua, *PatientAccessLog* masih dikaitkan secara langsung dengan fungsionalitas pencabutan hak akses (*revoke access*). Ketika hak akses dicabut, informasi pada entri log yang sama akan diperbarui dengan mengubah status akses menjadi *revoked*. Pendekatan tersebut menyebabkan isi log dapat berubah setelah dibuat sehingga tidak memenuhi karakteristik integritas dan kerahasiaan audit trail yang telah diuraikan pada Subbab ??, yang mensyaratkan bahwa catatan yang telah dibuat harus terlindungi dari upaya perusakan (*tampering*). Dalam konteks audit trail, setiap aktivitas yang telah terjadi seharusnya dipertahankan sebagai catatan historis yang tidak berubah, sedangkan perubahan kondisi akibat aktivitas berikutnya dicatat sebagai *audit record* baru yang terpisah, konsisten dengan pembedaan *audit record*, *audit log*, dan *audit trail* pada Subbab ??. Akibatnya, aktivitas pemberian dan pencabutan hak akses tidak terdokumentasi sebagai dua peristiwa yang berdiri sendiri sehingga kronologi aktivitas menjadi kurang akurat.

Selain *PatientAccessLog*, DecMed juga memanfaatkan *transaction block* pada jaringan IOTA sebagai bukti transaksi yang terjadi di dalam sistem. Setiap pemanggilan fungsi *smart contract* akan menghasilkan sebuah *transaction block* yang tersimpan secara terdistribusi pada jaringan IOTA. Mekanisme ini memberikan jaminan integritas yang tinggi karena data transaksi bersifat *immutable* dan sulit dimodifikasi setelah berhasil dikonfirmasi oleh jaringan, sejalan dengan karakteristik *immutability* pada DLT yang telah diuraikan pada Subbab II.4.1.

Meskipun memiliki keunggulan pada aspek integritas, *transaction block* IOTA tidak dirancang sebagai media *audit trail*. Struktur data transaksi lebih berorientasi pada kebutuhan validasi transaksi pada jaringan DLT sehingga kurang mudah dipahami oleh auditor maupun administrator sistem. Selain itu, proses pencarian (*searching*) dan analisis transaksi juga kurang efisien karena tidak tersedia mekanisme *query*, indeks, maupun agregasi log yang memadai, sehingga belum memenuhi komponen pembacaan event yang telah diuraikan pada Subbab ???. Kondisi tersebut menyulitkan proses investigasi ketika jumlah transaksi semakin besar. Di sisi lain, *transaction block* juga belum dapat menjamin retensi jangka panjang karena data transaksi pada node IOTA dapat dihapus melalui mekanisme *pruning*, sehingga belum memenuhi kebutuhan retensi pada komponen penyimpanan event yang telah diuraikan pada Subbab ??.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa DecMed telah memiliki beberapa bentuk pencatatan aktivitas, namun belum memiliki sebuah sistem *audit trail* yang terintegrasi. Audit record masih tersebar pada beberapa komponen dengan karakteristik yang berbeda, belum tersedia mekanisme pengelolaan yang mampu menjaga integritas dan retensi audit trail, serta belum tersedia fasilitas yang mendukung proses pencarian maupun analisis audit trail secara efisien. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bukti digital dalam proses audit maupun investigasi insiden keamanan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan suatu sistem *audit trail* yang mampu menghasilkan *audit record* dari berbagai komponen sistem, mengelolanya secara terpusat, serta menyediakan mekanisme penyimpanan yang mampu menjaga integritas, mendukung retensi, dan mempermudah proses analisis sebagai bukti digital dalam investigasi insiden keamanan.

III.1.2 Analisis Ancaman DecMed

III.1.2.1 Dekomposisi Aplikasi

Dekomposisi aplikasi merupakan tahap awal proses *threat modeling* yang bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sistem DecMed dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas eksternal. Dekomposisi ini terdiri atas

deskripsi sistem, dependensi eksternal, titik masuk, aset, dan level kepercayaan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi proses klasifikasi ancaman menggunakan metode STRIDE.

III.1.2.1.1 Deskripsi Sistem DecMed adalah kerangka kerja manajemen Rekam Medis Elektronik (RME) terdesentralisasi yang dibangun di atas Distributed Ledger Technology (DLT) IOTA. Sistem ini mengimplementasikan Capability-Based Access Control (CapBAC), Proxy Re-Encryption (PRE), dan InterPlanetary File System (IPFS) untuk menjamin kepemilikan data medis oleh pasien. Pasien secara aktif memberikan atau mencabut akses, menentukan durasi akses, dan berbagi data secara selektif dengan tenaga kesehatan. Sistem diimplementasikan menggunakan *smart contract* berbahasa Move pada ledger IOTA, sementara data klinis terenkripsi disimpan pada IPFS.

Arsitektur sistem terdiri atas tiga lapisan (*tiers*):

- **Client Layer** – antarmuka utama bagi seluruh aktor, dengan aplikasi *client* yang disesuaikan per peran (mobile untuk pasien, desktop untuk tenaga fasyankes dan Kementerian Kesehatan), dibangun menggunakan *framework* Tauri (Rust + SvelteKit/TypeScript).
- **Proxy Layer** – middleware keamanan yang menegakkan kebijakan akses dan menangani operasi kriptografis (PRE), terdiri atas PRE Server (Rust, Axum) dan Gas Station Server.
- **Storage Layer** – terbagi menjadi penyimpanan *on-chain* (IOTA ledger, untuk metadata dan *capability* akses) dan *off-chain* (IPFS untuk data klinis terenkripsi, Redis untuk data sementara seperti *nonce* dan *kfrag*).

Seluruh akses terhadap data RME pasien oleh pihak lain wajib melalui Proxy, dan setiap pemberian akses oleh pasien dicatat sebagai entri *capability* pada penyimpanan *on-chain* yang bersifat *immutable*, membentuk fondasi model CapBAC pada sistem DecMed.

III.1.2.1.2 Dependensi Eksternal Dependensi eksternal merupakan objek di luar kode aplikasi yang keberadaannya dapat menimbulkan ancaman terhadap sistem. Setiap dependensi diberi nomor unik dan deskripsi.

Tabel III.1: Dependensi Eksternal Sistem DecMed

ID	Deskripsi
DE-01	IOTA Rebased – DLT berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) dengan konsensus Mysticeti (Byzantine Fault Tolerant, Delegated Proof-of-Stake), finalitas transaksi ~500 ms, mendukung lebih dari 50.000 TPS.
DE-02	Smart Contract Move – <i>package</i> decmed yang dipublikasikan pada IOTA Layer 1, terdiri atas modul patient, admin, hospital_personnel, proxy, shared, serta modul struktur data <code>std_struct_*</code> dan <code>std_enum_*</code> .
DE-03	PRE Server – diimplementasikan dengan Rust dan <i>framework</i> Axum, menyediakan endpoint REST untuk proses autentikasi, pertukaran kunci, dan operasi RME.
DE-04	IOTA Gas Station – terdiri atas Gas Station Server (endpoint reservasi dan eksekusi <i>gas object</i>), Gas Station Storage (berbasis Redis dengan skrip LUA untuk akses konkuren), dan Key Store Manager/KSM (KMS eksternal atau penyimpanan kunci <i>in-memory</i>).
DE-05	Redis – digunakan oleh PRE Server untuk menyimpan data sementara seperti <i>nonce</i> autentikasi (TTL 3 menit) dan material PRE seperti <i>kfrag</i> (TTL 2 jam); juga digunakan oleh Gas Station sebagai <i>storage gas object</i> .
DE-06	IPFS Cluster – penyimpanan <i>off-chain</i> terdesentralisasi berbasis <i>content-addressing</i> (CID) untuk data klinis pasien yang telah dienkripsi, digunakan karena ukuran data klinis dapat melebihi batas objek IOTA (250 KB).
DE-07	Client Application Framework – Tauri (Rust + SvelteKit/TypeScript), dengan tiga varian: Patient Client (mobile), Hospital Client (desktop), dan Ministry Client (desktop).
DE-08	Skema BIP39 – standar <i>mnemonic</i> 12 kata untuk pembuatan dan pemulihan kunci kriptografis pasien dan tenaga fasyankes secara <i>non-custodial</i> .
DE-09	Mekanisme kriptografis Proxy Re-Encryption (PRE) dan AES-GCM – digunakan untuk enkripsi data administratif dan klinis serta proses re-enkripsi <i>ciphertext</i> bagi penerima yang berwenang.

III.1.2.1.3 Titik Masuk Titik masuk merupakan antarmuka pada aplikasi yang menjadi media interaksi antara pengguna (atau penyerang) dengan aplikasi maupun data. Setiap titik masuk diberi nomor unik, deskripsi, dan level kepercayaan minimum yang mengacu pada Tabel III.4.

Tabel III.2: Titik Masuk Sistem DecMed

ID	Nama	Deskripsi	Level Kepercayaan
TM-01	POST /nonce	Endpoint PRE Server untuk memperoleh <i>nonce</i> autentikasi 64-byte, divalidasi melalui <i>Move call is_account_registered</i> .	LK1–LK2
TM-02	POST /keys	Endpoint PRE Server untuk menyimpan material PRE (<i>kfrag</i> , kunci publik) dan menerbitkan token akses JWT bagi tenaga fasyankes.	LK2
TM-03	GET /medical-record	Endpoint PRE Server untuk mengambil metadata administratif dan klinis pasien beserta proses re-enkripsi, memerlukan token akses <i>read</i> yang valid.	LK4
TM-04	POST /medical-record	Endpoint PRE Server untuk membuat entri RME klinis baru, memerlukan token akses <i>update</i> .	LK4
TM-05	PUT /medical-record	Endpoint PRE Server untuk mengubah entri RME klinis yang sudah ada pada kunjungan yang sama.	LK4

ID	Nama	Deskripsi	Level Kepercayaan
TM-06	GET /medical-record/update	Endpoint PRE Server untuk mengambil metadata RME sebelum proses pengubahan (edit).	LK4
TM-07	GET /administrative	Endpoint PRE Server untuk mengambil metadata administratif pasien, dapat diakses oleh admin fasyankes maupun tenaga administratif.	LK3, LK5
TM-08	Modul decmed::patient	Kumpulan <i>method on-chain</i> yang dapat dieksekusi pasien: <code>signup</code> , <code>create_access</code> , <code>revoke_access</code> , <code>update_administrative_metadata</code> , <code>get_medical_record(s)</code> , <code>get_access_log</code> , dan sejenisnya.	LK1–LK2
TM-09	Modul decmed::hospital_personnel	Kumpulan <i>method on-chain</i> bagi tenaga fasyankes: <code>signup</code> , <code>use_activation_key</code> , <code>create_activation_key</code> , <code>cleanup_read/update_access</code> , <code>get_read/update_access</code> , dan sejenisnya.	LK3–LK5

ID	Nama	Deskripsi	Level Kepercayaan
TM-10	Modul decmed::admin	Kumpulan <i>method on-chain</i> bagi Kementerian Kesehatan: <i>create_activation_key</i> (registrasi fasyankes), <i>update_activation_key</i> , <i>get_hospitals</i> .	LK6
TM-11	Modul decmed::proxy	Kumpulan <i>method on-chain</i> yang dieksekusi oleh PRE Server: <i>create_capability</i> , <i>create/update_medical_record</i> , <i>get_administrative_data</i> , <i>get_hospital_personnel_role</i> , dan sejenisnya.	LK7
TM-12	Gas Station endpoint (<i>reserve & execute</i>)	Dua endpoint utama Gas Station Server untuk mencadangkan objek <i>gas</i> dan mengeksekusi transaksi tersponsori atas nama <i>client</i> .	LK7, LK8
TM-13	QR Code Delegasi Akses	Antarmuka fisik/visual berisi <i>iota_address</i> dan <i>pre_public_key</i> tenaga medis, dipindai oleh Patient Client untuk memulai proses delegasi akses.	LK2, LK4

ID	Nama	Deskripsi	Level Kepercayaan
TM-14	Sign-in lokal (PIN/biometrik)	Mekanisme autentikasi harian pasien/tenaga fasyankes menggunakan PIN atau biometrik terhadap kunci privat yang tersimpan terenkripsi di perangkat.	LK1–LK5

III.1.2.1.4 Aset Aset merupakan hal fisik maupun abstrak yang dimiliki sistem dan menjadi target ketertarikan penyerang. Setiap aset diberi nomor unik, deskripsi, dan level kepercayaan yang mengacu pada Tabel III.4.

Tabel III.3: Aset Sistem DecMed

ID	Nama	Deskripsi
A-01	Data administratif RME	Identitas dan data sosial pasien (NIK, nama, dsb.), terenkripsi AES-GCM sebelum disimpan <i>on-chain</i> .
A-02	Data klinis RME	Data pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis, terenkripsi AES-GCM dan disimpan pada IPFS sebagai <code>enc_medical_data</code> .
A-03	Entri <i>capability</i> akses (<i>on-chain</i>)	Struktur data <code>hospital_personnel_access_data</code> berisi <code>access_data_types</code> , <code>exp</code> (durasi kedaluwarsa), <code>metadata</code> , dan <code>medical_metadata_index</code> – fondasi model CapBAC.
A-04	<i>Recovery phrase</i> (BIP39) & kunci privat pasien/personel	<i>Mnemonic</i> 12 kata dan kunci privat turunannya, disimpan terenkripsi pada perangkat menggunakan <i>secure hardware</i> .
A-05	Material PRE (<code>kfrag</code> , <code>cfrag</code> , <i>pre_secret/public_key</i>)	Komponen kriptografis yang memungkinkan proses re-enkripsi data pasien kepada penerima yang berwenang.

ID	Nama	Deskripsi
A-06	<i>Nonce</i> autentikasi	Nilai acak 64-byte, TTL 3 menit, disimpan di Redis untuk mencegah serangan <i>replay</i> pada proses autentikasi pasien.
A-07	Token akses JWT	Token dengan klaim <i>role</i> dan <i>access type</i> (Read/Update); durasi berbeda antara tenaga medis (15 menit baca, 2 jam tulis) dan tenaga administratif.
A-08	<i>Activation key</i>	Kredensial sekali pakai yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (untuk admin fasyankes) dan admin fasyankes (untuk personel), berfungsi sebagai <i>cryptographic witness</i> atas tindakan yang diotorisasi.
A-09	GlobalAdminCap & ProxyCapEnum	Representasi <i>capability</i> tertinggi pada sistem – masing-masing untuk Kementerian Kesehatan dan PRE Server; kompromi terhadap aset ini setara dengan eskalasi privilege total.
A-10	CID data klinis (IPFS)	<i>Content Identifier</i> yang menjadi referensi lokasi dan <i>fingerprint</i> integritas data klinis terenkripsi pada IPFS.
A-11	<i>Gas object</i> & kunci penandatanganan Gas Station	Token IOTA yang dipecah menjadi objek <i>gas</i> untuk mensponsori transaksi, beserta kunci penandatanganan yang dikelola KSM.
A-12	Log akses RME	Catatan riwayat akses terhadap data RME pasien, dapat dilihat pasien melalui <code>get_access_log</code> .

III.1.2.1.5 Level Kepercayaan Level kepercayaan merepresentasikan hak akses yang diberikan sistem kepada suatu entitas eksternal maupun proses internal. Penentuan level kepercayaan pada sistem DecMed menggunakan pendekatan gabungan (*hybrid*) antara *role* untuk entitas eksternal (manusia) dan *capability* untuk proses/entitas internal, mengingat sistem DecMed secara eksplisit mengimplementasikan model Capability-Based Access Control (CapBAC).

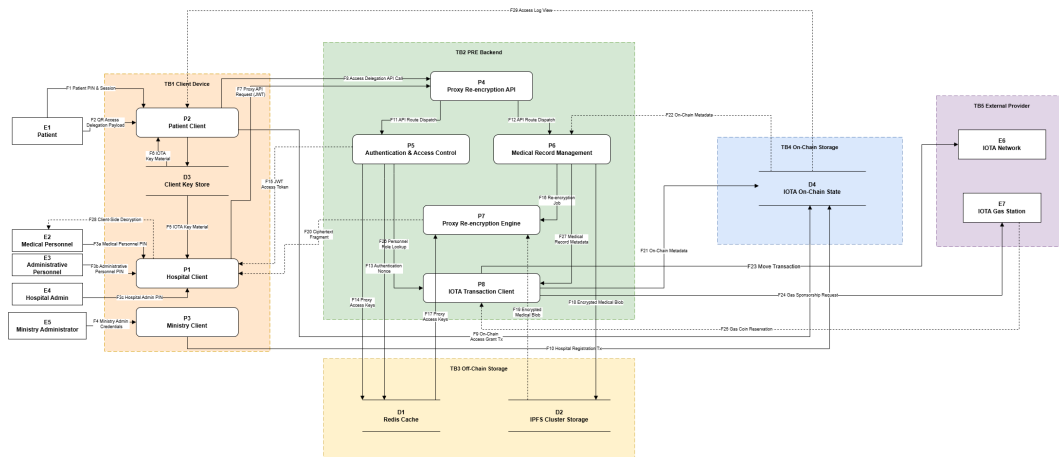
Tabel III.4: Level Kepercayaan Sistem DecMed

ID	Nama	Deskripsi
LK1	Aktor belum teraktivasi/terregistrasi	Pengguna yang belum menyelesaikan proses <i>signup</i> atau aktivasi <i>client</i> ; tidak memiliki <i>capability</i> apa pun pada sistem.
LK2	Pasien (teraktivasi)	Pasien yang telah teregistrasi; memiliki <i>capability</i> membaca RME sendiri, memberi dan mencabut akses, serta melihat log akses.
LK3	Administrative Personnel (dengan <i>capability</i> aktif)	Tenaga administratif fasyankes yang telah diberi akses oleh pasien; <i>scope</i> akses terbatas pada data administratif saja.
LK4	Medical Personnel (dengan <i>capability</i> aktif)	Tenaga medis fasyankes yang telah diberi akses oleh pasien; <i>scope</i> akses mencakup data administratif dan klinis, termasuk hak tulis (tambah/ubah) data klinis.
LK5	Hospital Admin	Administrator fasyankes; berwenang menambah personel dan menerbitkan <i>activation key</i> pada lingkup fasyankesnya.
LK6	Ministry of Health	Administrator Kementerian Kesehatan; berwenang meregistrasi fasyankes baru beserta adminnya, otoritas tertinggi di antara aktor manusia.
LK7	PRE Server (Proxy)	Proses <i>backend</i> dengan <i>capability</i> ProxyCapEnum; berwenang memverifikasi entri <i>capability on-chain</i> dan melakukan re-enkripsi data.
LK8	Gas Station Server	Proses <i>backend</i> yang mensponsori dan mengeksekusi transaksi atas nama <i>client</i> , memiliki akses terhadap kunci penandatanganan (KSM).
LK9	IOTA Network Validator	Node jaringan yang berpartisipasi dalam konsensus Mysticeti untuk memvalidasi dan memfinalisasi transaksi pada ledger IOTA.

Catatan: LK3 dan LK4 bersifat *paralel*, bukan hierarkis – keduanya diberikan *ca-*

pability oleh pasien secara independen dengan cakupan data yang berbeda (administratif saja vs. administratif dan klinis), sehingga tidak dapat diasumsikan LK4 selalu memiliki privilege lebih tinggi dari LK3 di seluruh konteks ancaman.

III.1.2.1.6 Data Flow Diagram Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data antara entitas eksternal, proses, dan penyimpanan data pada sistem DecMed secara visual, sebagai dasar identifikasi elemen yang akan diklasifikasikan ancamannya menggunakan metode STRIDE pada subbab berikutnya. DFD sistem DecMed digambarkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1: Data Flow Diagram Sistem DecMed

DFD tersebut menggambarkan interaksi antara entitas eksternal (aktor), proses, dan penyimpanan data yang telah diidentifikasi pada dependensi eksternal (Tabel III.1), titik masuk (Tabel III.2), aset (Tabel III.3), dan level kepercayaan (Tabel III.4) pada subbab sebelumnya. Elemen-elemen pada DFD tersebut menjadi dasar penomoran dan referensi pada proses klasifikasi ancaman menggunakan metode STRIDE (III.1.2.2).

III.1.2.2 Klasifikasi Ancaman

Klasifikasi ancaman dilakukan menggunakan pendekatan *STRIDE-per-Interaction*. Setiap interaksi antar elemen pada Data Flow Diagram (Gambar III.1) diperiksa berdasarkan arah dan tipe interaksinya (*process* ke *data store*, *process* ke *process*, *data flow* yang melintasi *machine boundary*, dsb.), kemudian kategori STRIDE yang dianalisis dibatasi hanya pada kategori yang relevan bagi tipe interaksi tersebut, mengacu pada Tabel II.2. Pendekatan ini memberikan justifikasi eksplisit atas kategori yang dipilih maupun yang tidak dianalisis untuk setiap ancaman.

Elemen E6 IOTA Network dan E7 IOTA Gas Station pada TB5 External Provider diperlakukan sebagai infrastruktur eksternal tepercaya yang berada di luar kendali sistem DecMed; ancaman terhadap operasional internal keduanya berada di luar cakupan *threat model* ini, dan hanya interaksinya dengan sistem (melalui P8, sebagai *process* yang mengirim output ke *external interactor*) yang dianalisis.

Hasil klasifikasi ancaman disajikan pada Tabel III.5, dengan kolom **Tipe Interaksi** merujuk pada nomor baris interaksi di Tabel II.2 yang menjadi dasar penentuan kategori STRIDE bagi ancaman terkait.

Tabel III.5: Klasifikasi Ancaman Sistem DecMed

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T1	Penyerang mendapatkan kredensial atau membajak sesi lokal milik pengguna untuk berpura-pura menjadi pemilik identitas sah saat <i>sign-in</i> .	E1–E5, P1, P2, P3	LK1–LK6	7, 11	S
T2	Kredensial <i>sign-in</i> (PIN) tersadap atau terekam melalui <i>shoulder surfing</i> , <i>keylogger</i> , atau malware pada perangkat saat dimasukkan ke Client.	E1–E5, P1, P2, P3	LK1–LK6	7, 11	I
T3	Percobaan <i>sign-in</i> berulang secara masif menghabiskan sumber daya Client (<i>local resource exhaustion</i>).	E1–E5, P1, P2, P3	LK1	7	D
T4	Payload QR Access Delegation dipalsukan sebelum dipindai oleh Patient Client.	P2, F2	LK2, LK4	7	S

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T5	Payload QR Access Delegation disadap sehingga informasi delegasi akses bocor kepada pihak tidak berwenang.	P2, F2	LK2, LK4	7	I
T6	Pasien menyangkal pernah memberikan akses (<i>create_access</i>) kepada tenaga medis tertentu.	E1, P2, P8	LK2	11	R
T7	Tenaga medis atau tenaga administratif menyangkal pernah mengakses maupun mengubah data pasien tertentu.	E2, E3, P1, P6	LK3, LK4	11	R
T8	Admin fasyankes menyangkal pernah menerbitkan <i>activation key</i> kepada personel tertentu.	E4, P1	LK5	11	R
T9	Ministry Administrator menyangkal pernah meregistrasi fasyankes tertentu beserta admin-nya.	E5, P3	LK6	11	R
T10	Penyerang menyamar sebagai Proxy Re-encryption API (P4) yang sah (<i>man-in-the-middle</i>) saat Client mengirim permintaan, karena flow melintasi batas perangkat (<i>client-backend</i>).	P1, P2, P4, F7, F8	LK2–LK4	2, 8	S

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T11	Penyerang menyadap komunikasi Client–PRE Server yang melintasi batas perangkat, mengungkapkan token JWT maupun data administratif.	P1, P2, P4, F7, F8, F15	LK2– LK4	8	I
T12	Pihak eksternal membanjiri <i>endpoint</i> POST /nonce atau POST /keys dengan permintaan palsu untuk menghabiskan sumber daya PRE Server.	P4, P5, F7, F8	LK1	7	D
T13	Token JWT dipalsukan atau diputar ulang (<i>replay</i>) pada permintaan dari Proxy Re-encryption API ke Medical Record Management.	P4, P6, F12	LK3, LK4	2	S
T14	Penyadapan jalur <i>dispatch</i> internal dari Proxy Re-encryption API ke Authentication/Medical Record Management mengungkapkan data yang sedang diproses.	P4, P5, P6, F11, F12	LK7	2	I

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T15	Penyerang memodifikasi <i>Move transaction</i> pada jalur dari IOTA Transaction Client menuju IOTA Network, karena flow melintasi batas sistem DecMed dengan infrastruktur eksternal.	P8, F23	LK7, LK8	3, 8	T
T16	Penyerang menyamar sebagai IOTA Transaction Client (P8) yang sah saat berinteraksi dengan Gas Station untuk mengajukan sponsorship transaksi palsu.	P8, F24	LK7, LK8	3	S
T17	PRE Server (P8) menyangkal telah mengajukan atau menerima keputusan sponsorship transaksi tertentu dari Gas Station.	P8, F24, F25	LK7, LK8	3	R
T18	Penyerang mengajukan permintaan sponsorship <i>gas</i> secara berulang sehingga <i>gas object</i> habis dan transaksi sah pengguna lain gagal tersponsori.	P8, F24, F25	LK1–LK4	3	D
T19	Penyerang dengan akses tidak sah memodifikasi kunci privat atau material PRE yang tersimpan pada Client Key Store.	D3, P1, P2, F5, F6	LK1	5, 10	T

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T20	Penyerang dengan akses fisik ke perangkat yang tidak terkunci membaca kunci privat pada Client Key Store.	D3, F5, F6	LK1	10	I
T21	Pihak dengan akses tidak sah ke Redis memodifikasi nilai <i>nonce</i> autentikasi atau kfrag sebelum digunakan.	D1, P4, P5, P7, F13, F14	LK7	5, 10	T
T22	Pihak dengan akses tidak sah ke Redis membaca kfrag atau <i>nonce</i> sebelum masa berlakunya (TTL) berakhir.	D1	LK7	10	I
T23	Redis dipenuhi (<i>memory exhaustion</i>) melalui permintaan <i>nonce</i> baru secara berulang sehingga proses autentikasi pengguna sah terganggu.	D1, F13	LK1	5	D
T24	Data klinis terenkripsi diunduh dari IPFS Cluster Storage oleh pihak tidak berwenang; risiko pengungkapan tetap ada apabila kunci enkripsi terkait bocor atau lemah.	D2, F18, F19	LK1, publik	10	I

ID	Deskripsi Ancaman	Elemen DFD	Level Kepercayaan	Tipe Interaksi	STRIDE
T25	IPFS Cluster dibanjiri permintaan <i>fetch/pin</i> berukuran besar sehingga mengganggu ketersediaan data klinis bagi pengguna sah.	D2	publik	5	D
T26	Metadata <i>on-chain</i> yang tersimpan pada IOTA On-Chain State bersifat publik sehingga pola transaksi berpotensi dianalisis untuk mengungkapkan informasi tidak langsung mengenai pasien.	D4, F21, F22	LK9, publik	10	I
T27	Kelemahan validasi <i>capability on-chain</i> memungkinkan pembacaan atau pembuatan ProxyCapEnum/GlobalAdminCap tanpa otorisasi sah, setara privilese tertinggi PRE Server/Kementerian Kesehatan.	P7, D4	LK2/LK4 → LK6/LK7	5	E
T28	Kegagalan validasi otorisasi pada Authentication & Access Control memungkinkan Medical Record Management memproses permintaan dengan <i>scope</i> lebih tinggi dari yang seharusnya (administratif → klinis).	P5, P6, F26	LK3 → LK4	2	E

III.1.3 Analisis Kebutuhan Audit Event

Berdasarkan hasil analisis ancaman menggunakan metode STRIDE pada bagian sebelumnya, tahap selanjutnya adalah menentukan kebutuhan audit trail yang diperlukan untuk menghasilkan bukti digital terhadap setiap ancaman yang teridentifikasi. Kebutuhan tersebut diperoleh dengan memetakan setiap ancaman ke aktivitas sistem yang perlu dicatat sebagai audit event. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan mekanisme audit pada DecMed serta menjadi masukan bagi perancangan sistem audit trail pada bab selanjutnya. Hasil pemetaan antara ancaman, kebutuhan bukti digital, dan audit event yang dihasilkan ditunjukkan pada Tabel III.6.

Tabel III.6: Pemetaan Ancaman ke Audit Event

Threat	Bukti yang Dibutuhkan	Audit Event
T1, T2, T3	Identitas pengguna, metode autentikasi, hasil autentikasi, waktu, perangkat, serta frekuensi percobaan autentikasi.	Authentication
T4, T5	Payload QR Access Delegation, hasil validasi, identitas pembuat dan pemindai QR.	QR Access Delegation Validation
T6	Identitas pasien, penerima akses, <i>capability</i> yang dibuat, waktu, serta <i>transaction digest</i> .	Capability Creation
T7, T13	Identitas pengguna, jenis operasi (<i>read/write</i>), objek rekam medis, <i>capability</i> yang digunakan, serta hasil validasi otorisasi.	Medical Record Access

Threat	Bukti yang Dibutuhkan	Audit Event
T8	Identitas Hospital Administrator, penerima <i>activation key</i> , dan waktu penerbitan.	Activation Key Issuance
T9	Identitas Ministry Administrator, identitas fasyankes yang diregistrasi, waktu, serta <i>transaction digest</i> .	Healthcare Facility Registration
T10, T11, T12	Identitas pemohon, layanan PRE yang diminta, endpoint tujuan, waktu, dan hasil pemrosesan permintaan.	PRE Service Request
T14	Identitas pemohon, aktivitas <i>re-encryption</i> , objek yang diproses, dan hasil operasi.	Re-encryption Operation
T15	<i>Transaction digest</i> , identitas penandatanganan, payload transaksi, dan hasil pengiriman transaksi.	Blockchain Transaction Submission
T16, T18	Identitas pemohon sponsorship, <i>transaction digest</i> , waktu, serta frekuensi permintaan sponsorship.	Gas Sponsorship Request
T17	Identitas pemohon, keputusan sponsorship, dan <i>transaction digest</i> .	Gas Sponsorship Decision
T19	Jenis kunci yang dimodifikasi, jenis operasi, dan identitas pelaku.	Client Key Store Operation

Threat	Bukti yang Dibutuhkan	Audit Event
T20	Jenis kunci yang diakses, identitas pelaku, dan waktu akses.	Client Key Store Access
T21, T23	Objek sensitif (<i>nonce/kfrag</i>), jenis operasi, identitas proses, dan waktu operasi.	Sensitive Cache Object Operation
T22	Objek sensitif yang diakses, identitas proses, dan waktu akses.	Sensitive Cache Object Access
T24	Content Identifier (CID), identitas pemohon, jenis operasi, dan waktu akses.	IPFS Object Access
T25	CID, nilai hash, hasil verifikasi integritas, dan waktu verifikasi.	IPFS Object Integrity Verification
T26	Objek <i>on-chain</i> yang diakses, identitas pemohon, dan waktu akses.	On-chain Metadata Access
T27, T28	Capability ID, identitas pemohon, hasil validasi otorisasi, serta alasan penolakan apabila validasi gagal.	Capability Validation

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diperoleh sekumpulan audit event yang mewakili aktivitas-aktivitas penting pada sistem DecMed. Satu audit event dapat digunakan sebagai bukti terhadap lebih dari satu ancaman apabila ancaman tersebut memiliki kebutuhan bukti digital yang serupa. Daftar audit event hasil identifikasi tersebut ditunjukkan pada Tabel III.7.

Tabel III.7: Daftar Audit Event Hasil Identifikasi

ID	Audit Event	Deskripsi Aktivitas
EV1	Authentication	Pencatatan setiap percobaan autentikasi pengguna ke Client, baik berhasil maupun gagal.
EV2	QR Access Delegation Validation	Pencatatan proses validasi payload QR Access Delegation sebelum akses diberikan kepada tenaga fasyankes.
EV3	Capability Creation	Pencatatan aktivitas pembuatan <i>capability</i> akses oleh pasien kepada tenaga fasyankes.
EV4	Medical Record Access	Pencatatan aktivitas pembacaan maupun perubahan data rekam medis.
EV5	Activation Key Issuance	Pencatatan aktivitas penerbitan <i>activation key</i> kepada personel fasyankes.
EV6	Healthcare Facility Registration	Pencatatan aktivitas registrasi fasyankes beserta administrasinya.
EV7	PRE Service Request	Pencatatan setiap permintaan layanan yang diterima PRE Server.
EV8	Re-encryption Operation	Pencatatan aktivitas re-enkripsi data oleh PRE Server.
EV9	Blockchain Transaction Submission	Pencatatan aktivitas pembuatan, penandatanganan, dan pengiriman transaksi ke jaringan IOTA.
EV10	Gas Sponsorship Request	Pencatatan aktivitas permintaan sponsorship transaksi kepada Gas Station.
EV11	Gas Sponsorship Decision	Pencatatan keputusan Gas Station terhadap permintaan sponsorship transaksi.
EV12	Client Key Store Operation	Pencatatan aktivitas pembuatan, perubahan, maupun penghapusan material kriptografi pada Client Key Store.
EV13	Client Key Store Access	Pencatatan aktivitas akses terhadap material kriptografi pada Client Key Store.

ID	Audit Event	Deskripsi Aktivitas
EV14	Sensitive Cache Object Operation	Pencatatan aktivitas penyimpanan maupun perubahan objek sensitif pada Redis.
EV15	Sensitive Cache Object Access	Pencatatan aktivitas pembacaan objek sensitif pada Redis.
EV16	IPFS Object Access	Pencatatan aktivitas pengunggahan maupun pengunduhan objek pada IPFS.
EV17	IPFS Object Integrity Verification	Pencatatan proses verifikasi integritas objek yang tersimpan pada IPFS.
EV18	On-chain Metadata Access	Pencatatan aktivitas pembacaan metadata maupun objek pada ledger IOTA.
EV19	Capability Validation	Pencatatan proses validasi <i>capability</i> sebelum permintaan diproses lebih lanjut.

III.1.3.0.1 Identifikasi Atribut Audit Setelah diperoleh daftar *audit event* pada Tabel III.7, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi atribut yang perlu dicatat setiap kali *audit event* tersebut terjadi. Kumpulan atribut tersebut membentuk sebuah *audit record* yang menjadi bukti digital atas aktivitas sistem. Penentuan atribut audit dilakukan dengan mengacu pada kontrol AU-3 *Content of Audit Records* pada NIST SP 800-53 Rev. 5 National Institute of Standards and Technology, 2020, yang menyatakan bahwa setiap *audit record* harus memuat informasi mengenai (a) jenis *event* yang terjadi, (b) waktu kejadian, (c) lokasi atau sumber kejadian, (d) sumber *event*, (e) hasil (*outcome*) dari *event*, serta (f) identitas individu, subjek, maupun objek yang terlibat.

Keenam elemen tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk atribut audit umum yang dicatat pada seluruh *audit event* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.8. Selain atribut umum tersebut, setiap *audit event* juga memiliki atribut tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik aktivitas sistem dan kebutuhan bukti digital terhadap ancaman yang dipetakan sebelumnya. Atribut tambahan tersebut disajikan pada Tabel III.9.

Field *record_id* dan *prev_record_hash* tidak secara eksplisit disyaratkan oleh kontrol AU-3. Kedua atribut tersebut ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan rancangan *audit trail* pada penelitian ini, khususnya dalam menjamin identitas unik

Tabel III.8: Skema Umum Atribut Audit

Atribut	Deskripsi	Elemen AU-3
record_id	Pengenal unik setiap <i>audit record</i> (UUID) yang tidak dapat digunakan ulang.	–
event_type	Jenis <i>audit event</i> yang terjadi, mengacu pada daftar <i>audit event</i> pada Tabel III.7.	(a)
timestamp	Waktu terjadinya <i>audit event</i> dengan presisi milidetik dalam format UTC.	(b)
source_component	Komponen atau proses sistem yang menghasilkan <i>audit event</i> .	(c), (d)
actor_id	Identitas aktor yang memicu <i>audit event</i> , seperti <i>IOTA address</i> , <i>role</i> , atau <i>session ID</i> .	(f)
target_object	Identitas objek atau sumber daya yang menjadi target aktivitas, misalnya ID rekam medis, ID <i>capability</i> , atau CID IPFS.	(f)
outcome	Hasil pelaksanaan <i>audit event</i> , seperti <i>success</i> , <i>failure</i> , atau <i>denied</i> , beserta kode alasan apabila tersedia.	(e)
prev_record_hash	<i>Hash</i> dari <i>audit record</i> sebelumnya untuk membentuk mekanisme <i>hash chaining</i> yang mendukung sifat <i>append-only</i> dan <i>immutable</i> .	–

setiap *audit record* serta menjaga integritas rangkaian *audit record* melalui mekanisme *hash chaining*.

Tabel III.9: Atribut Audit Tambahan untuk Setiap Audit Event

ID Event	Atribut Tambahan	Alasan
EV1	auth_method, authentication_result, failed_attempt_count, device_fingerprint.	Mendukung identifikasi metode autentikasi, pola kegagalan autentikasi, serta anomali perangkat yang digunakan.
EV2	qr_payload_id, recipient_identity, signature_valid.	Membuktikan keaslian payload QR serta identitas pihak yang menerima delegasi akses.

ID Event	Atribut Tambahan	Alasan
EV3	capability_id, access_scope, expiry_duration, transaction_digest.	Mendokumentasikan capability yang diberikan beserta ruang lingkup akses dan transaksi yang merekamnya.
EV4	access_type, medical_record_id, capability_id, authorization_token_id.	Mengidentifikasi jenis akses terhadap rekam medis beserta capability dan token otorisasi yang digunakan.
EV5	activation_key_id, issuer_id, recipient_id, expiration_time.	Mencatat informasi penerbitan <i>activation key</i> beserta pihak penerbit dan penerimanya.
EV6	facility_id, facility_name, administrator_id, transaction_digest.	Mendokumentasikan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan beserta transaksi yang merekamnya.
EV7	endpoint_called, request_id, caller_component, channel_encryption.	Mengidentifikasi layanan PRE yang dipanggil beserta komponen pemanggil dan status pengamanan kanal komunikasi.
EV8	reencryption_operation_id, capability_id, target_ciphertext, kfrag_identifier.	Mendokumentasikan proses re-enkripsi yang dilakukan terhadap data terenkripsi.
EV9	transaction_digest, payload_hash, network_confirmation_status.	Menyediakan bukti pengiriman transaksi beserta status konfirmasi pada jaringan IOTA.
EV10	requested_gas_budget, requester_id, transaction_digest.	Mendokumentasikan permintaan sponsorship beserta kebutuhan gas transaksi.

ID Event	Atribut Tambahan	Alasan
EV11	approval_status, decision_reason, approved_by.	Mencatat keputusan sponsorship beserta alasan keputusan dan pihak yang memberikan persetujuan.
EV12	key_operation, key_id, key_type.	Mencatat aktivitas pembuatan, perubahan, maupun penghapusan material kriptografi.
EV13	key_id, key_type, access_purpose.	Mencatat aktivitas akses terhadap material kriptografi beserta tujuan penggunaannya.
EV14	redis_key_type, operation_type, ttl_remaining.	Mencatat aktivitas penyimpanan atau perubahan objek sensitif pada Redis.
EV15	redis_key_type, request_origin, ttl_remaining.	Mencatat aktivitas pembacaan objek sensitif beserta asal permintaan.
EV16	cid, operation_type, data_size.	Mencatat aktivitas unggah maupun unduh objek pada penyimpanan IPFS.
EV17	cid, expected_hash, verification_result.	Mendokumentasikan proses verifikasi integritas objek pada IPFS.
EV18	metadata_type, object_id, query_requester_id.	Mencatat aktivitas pembacaan metadata atau objek pada ledger IOTA.
EV19	capability_checked, required_scope, actual_scope, validation_result.	Mendokumentasikan proses validasi capability beserta hasil evaluasi hak akses.

III.1.3.0.2 Analisis Gap Audit Event Setelah diperoleh daftar *audit event* yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi apakah sistem DecMed telah menyediakan mekanisme pencatatan terhadap *audit event* tersebut. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan daftar *audit event* hasil identifikasi dengan mekanisme pencatatan yang telah tersedia pada DecMed, yaitu *PatientAccessLog* yang disimpan sebagai objek *on-chain* serta riwayat transaksi (*transaction history*) pada jaringan IOTA. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel III.10.

Tabel III.10: Analisis Gap Audit Event pada DecMed

ID	Audit Event	Kondisi Saat Ini	Analisis Gap
EV1	Authentication	Tidak tersedia	Tidak terdapat mekanisme pencatatan aktivitas autentikasi pengguna sehingga percobaan autentikasi berhasil maupun gagal tidak dapat dijadikan bukti audit.
EV2	QR Access Delegation Validation	Tidak tersedia	Proses validasi payload QR tidak menghasilkan audit record sehingga tidak tersedia bukti terhadap penyalahgunaan maupun manipulasi QR Access Delegation.
EV3	Capability Creation	Sebagian	Aktivitas tercatat pada <i>PatientAccessLog</i> dan transaksi <i>on-chain</i> , namun informasi yang dicatat masih terbatas dan belum dirancang sebagai audit trail yang terintegrasi.
EV4	Medical Record Access	Tidak tersedia	Aktivitas pembacaan maupun perubahan data rekam medis belum dicatat sebagai audit record sehingga sulit dilakukan penelusuran akses terhadap data pasien.
EV5	Activation Key Issuance	Tidak tersedia	Tidak tersedia mekanisme audit terhadap proses penerbitan <i>activation key</i> .

ID	Audit Event	Kondisi Saat Ini	Analisis Gap
EV6	Healthcare Facility Registration	Sebagian	Aktivitas registrasi direkam sebagai transaksi <i>on-chain</i> , namun belum tersedia audit record yang mendokumentasikan informasi kontekstual aktivitas registrasi.
EV7	PRE Service Request	Tidak tersedia	Aktivitas permintaan layanan pada PRE Server belum dicatat sebagai audit record.
EV8	Re-encryption Operation	Tidak tersedia	Proses <i>re-encryption</i> tidak menghasilkan bukti audit yang dapat digunakan dalam investigasi.
EV9	Blockchain Transaction Submission	Sebagian	Riwayat transaksi tersedia pada jaringan IOTA, namun hanya merekam hasil transaksi tanpa informasi operasional yang lengkap mengenai proses pengiriman transaksi.
EV10	Gas Sponsorship Request	Tidak tersedia	Tidak tersedia mekanisme audit terhadap permintaan sponsorship transaksi.
EV11	Gas Sponsorship Decision	Tidak tersedia	Keputusan pemberian maupun penolakan sponsorship belum dicatat sebagai audit record.
EV12	Client Key Store Operation	Tidak tersedia	Aktivitas pengelolaan material kriptografi pada sisi klien belum memiliki mekanisme audit.
EV13	Client Key Store Access	Tidak tersedia	Akses terhadap material kriptografi tidak menghasilkan bukti audit.
EV14	Sensitive Cache Object Operation	Tidak tersedia	Aktivitas penyimpanan objek sensitif pada Redis belum dicatat.

ID	Audit Event	Kondisi Saat Ini	Analisis Gap
EV15	Sensitive Cache Object Access	Tidak tersedia	Aktivitas pembacaan objek sensitif pada Redis belum dicatat.
EV16	IPFS Object Access	Tidak tersedia	Aktivitas unggah maupun unduh objek pada IPFS belum memiliki mekanisme audit.
EV17	IPFS Object Integrity Verification	Tidak tersedia	Tidak tersedia pencatatan terhadap proses verifikasi integritas objek pada IPFS.
EV18	On-chain Metadata Access	Tidak tersedia	Aktivitas pembacaan metadata maupun objek <i>on-chain</i> tidak dicatat sebagai audit record.
EV19	Capability Validation	Tidak tersedia	Proses validasi <i>capability</i> sebelum otorisasi akses belum menghasilkan audit record.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel III.10, dapat diketahui bahwa DecMed telah menyediakan mekanisme pencatatan terhadap sebagian aktivitas melalui *PatientAccessLog* dan riwayat transaksi pada jaringan IOTA. Namun, mekanisme tersebut hanya mencakup sebagian kecil *audit event* yang dibutuhkan serta belum dirancang sebagai sebuah sistem *audit trail*. Sebagian besar aktivitas penting, khususnya yang terjadi pada komponen *Client*, PRE Server, Redis, maupun IPFS, belum menghasilkan bukti audit yang dapat digunakan dalam proses audit maupun investigasi insiden keamanan. Selain itu, informasi yang tersedia pada mekanisme pencatatan yang telah ada masih bersifat terbatas dan tersebar pada beberapa komponen sehingga belum mampu menyediakan jejak audit yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme audit trail yang mampu mencatat seluruh *audit event* yang telah diidentifikasi secara terintegrasi.

III.1.4 Analisis Kebutuhan Sistem

III.1.4.1 Analisis Komponen Infrastruktur Audit Trail

Setelah kebutuhan *audit event* ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen infrastruktur yang diperlukan agar proses pencatatan, penyimpanan, pemantauan, dan analisis *audit trail* dapat berjalan secara menyeluruh. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada model konseptual sistem *audit trail* yang dijelaskan pada Annex B ISO 27789. Berbeda dengan NIST SP 800-53 yang mendefinisikan kontrol keamanan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem *audit trail*, ISO 27789 menyediakan model layanan (*service-oriented architecture*) yang menggambarkan komponen-komponen utama beserta interaksinya dalam membangun sebuah sistem *audit trail*.

Model tersebut menunjukkan bahwa sistem *audit trail* tidak hanya terdiri atas media penyimpanan log, tetapi merupakan sekumpulan layanan yang bekerja sama untuk menerima *audit event*, membentuk *audit record*, menyimpan data, melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang terjadi, hingga menyediakan fasilitas pencarian dan pelaporan bagi auditor. Berdasarkan model tersebut, komponen-komponen yang menjadi kebutuhan dasar infrastruktur *audit trail* dapat diidentifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.11.

Tabel III.11: Identifikasi Komponen Infrastruktur Audit Trail berdasarkan ISO 27789 Annex B

Komponen	Fungsi
Audit Logger	Menerima <i>audit event</i> dari aplikasi atau sistem, melakukan validasi awal, kemudian meneruskan <i>event</i> untuk diproses dan disimpan sebagai <i>audit record</i> .
Audit Record Generator	Membentuk <i>audit record</i> berdasarkan jenis <i>audit event</i> yang diterima sehingga seluruh <i>audit record</i> memiliki format yang konsisten.
Audit Event Catalogue	Menyediakan definisi, metadata, dan struktur setiap jenis <i>audit event</i> yang digunakan oleh sistem.
Audit Repository	Menyimpan seluruh <i>audit record</i> yang dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai bukti pada proses audit maupun investigasi.

Komponen	Fungsi
Audit Monitor	Melakukan pemantauan terhadap aliran <i>audit event</i> untuk mendeteksi pola atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Audit Alert	Menghasilkan notifikasi apabila Audit Monitor mendeteksi pola aktivitas yang memenuhi kondisi tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Audit Report	Menyediakan fasilitas pencarian, pengambilan, dan penyajian <i>audit record</i> untuk mendukung proses audit dan investigasi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa sistem *audit trail* menurut ISO 27789 terdiri atas beberapa layanan yang memiliki tanggung jawab berbeda namun saling melengkapi. Audit Logger Service berperan sebagai titik masuk seluruh *audit event*, sedangkan Audit Repository bertanggung jawab sebagai media penyimpanan utama. Di sisi lain, Audit Report Service menyediakan akses terhadap data audit untuk keperluan investigasi, sementara Audit Monitor Service dan Audit Alert Service mendukung kemampuan pemantauan secara *real-time* terhadap aktivitas yang dicatat. Selain itu, Audit Event Catalogue Service dan Audit Record Generator Service berfungsi menjaga konsistensi struktur *audit record* yang dihasilkan oleh berbagai aplikasi.

Komponen-komponen tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi eksisting pada arsitektur DecMed untuk mengidentifikasi komponen yang telah tersedia maupun komponen yang masih belum tersedia. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan infrastruktur *audit trail* yang akan dirancang pada penelitian ini.

III.1.4.2 Analisis Gap Infrastruktur Audit Trail terhadap DecMed

Setelah komponen-komponen utama infrastruktur *audit trail* diidentifikasi berdasarkan model konseptual ISO 27789, langkah selanjutnya adalah membandingkan model tersebut dengan kondisi eksisting sistem DecMed. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen infrastruktur *audit trail* yang telah tersedia maupun komponen yang masih belum tersedia pada arsitektur DecMed. Hasil analisis ter-

sebut digunakan untuk menentukan kebutuhan implementasi yang harus dipenuhi agar DecMed mampu mendukung proses pencatatan, penyimpanan, pemantauan, dan penyajian *audit trail* secara komprehensif.

Analisis dilakukan dengan mengevaluasi setiap komponen yang direkomendasikan oleh ISO 27789 terhadap arsitektur DecMed yang terdiri atas aplikasi klien, *smart contract* IOTA Move, *Proxy Re-Encryption Server*, serta infrastruktur penyimpanan data yang telah ada. Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel III.12.

Tabel III.12: Analisis Gap Infrastruktur Audit Trail terhadap DecMed

Komponen	Kondisi DecMed	Analisis Gap	Kebutuhan
Audit Logger Service	Belum tersedia. Audit event dicatat secara terpisah oleh masing-masing komponen.	Belum terdapat mekanisme terpusat untuk menerima seluruh audit event dari berbagai komponen sistem.	Diperlukan layanan yang bertugas menerima seluruh audit event sebelum diproses lebih lanjut.
Audit Record Generator Service	Belum tersedia.	Belum terdapat mekanisme pembentukan audit record yang konsisten sehingga struktur audit record bergantung pada implementasi masing-masing komponen.	Diperlukan mekanisme pembentukan audit record yang memiliki format dan atribut yang seragam.

Komponen	Kondisi DecMed	Analisis Gap	Kebutuhan
Audit Event Catalogue Service	Belum tersedia.	Belum terdapat definisi terpusat mengenai jenis audit event beserta atribut yang dimiliki.	Diperlukan katalog audit event sebagai acuan seluruh komponen dalam menghasilkan audit record.
Audit Repository	Belum tersedia.	DecMed belum memiliki repositori khusus untuk menyimpan audit trail secara terpusat. Riwayat akses pasien dan transaksi blockchain belum dapat berfungsi sebagai repositori audit trail yang komprehensif.	Diperlukan repositori khusus yang mampu menyimpan audit trail secara terpusat dan mendukung kebutuhan investigasi.
Audit Monitor Service	Belum tersedia.	Belum terdapat mekanisme pemantauan terhadap pola aktivitas atau kejadian mencurigakan secara otomatis.	Diperlukan mekanisme monitoring audit event sebagai dasar deteksi aktivitas tertentu.

Komponen	Kondisi DecMed	Analisis Gap	Kebutuhan
Audit Alert Service	Belum tersedia.	Belum terdapat mekanisme pemberian notifikasi ketika ditemukan aktivitas yang memenuhi kondisi tertentu.	Diperlukan layanan yang mampu menghasilkan notifikasi berdasarkan hasil pemantauan audit trail.
Audit Report Service	Sebagian tersedia melalui <i>Patient Access Log</i> .	Riwayat akses yang tersedia hanya mencakup aktivitas tertentu dan belum mendukung pencarian maupun pelaporan audit trail secara menyeluruh.	Diperlukan layanan pelaporan yang mampu melakukan pencarian dan penyajian audit trail untuk proses audit maupun investigasi.

Berdasarkan Tabel III.12, dapat dilihat bahwa sebagian besar komponen infrastruktur *audit trail* yang direkomendasikan oleh ISO 27789 belum tersedia pada arsitektur DecMed. Meskipun DecMed telah memiliki beberapa mekanisme pencatatan aktivitas, seperti *Patient Access Log* dan riwayat transaksi pada IOTA DLT, mekanisme tersebut belum membentuk sebuah sistem *audit trail* yang terintegrasi. Selain itu, belum tersedia layanan yang secara khusus bertanggung jawab untuk menerima *audit event*, membentuk *audit record*, menyimpan data audit secara terpusat, maupun menyediakan fasilitas pemantauan dan pelaporan.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem *audit trail* pada DecMed tidak hanya memerlukan penambahan media penyimpanan audit trail, tetapi juga memerlukan beberapa komponen layanan baru yang bekerja secara terintegrasi. Komponen-komponen tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan kontrol keamanan yang direkomendasikan oleh NIST SP 800-53 Revision 5 untuk menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap

komponen sebelum dilakukan proses perancangan sistem.

III.1.4.3 Analisis Kebutuhan Keamanan Infrastruktur Audit Trail

Selain kebutuhan terhadap komponen infrastruktur, sistem *audit trail* juga harus memenuhi kebutuhan keamanan agar informasi audit yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bukti yang valid dalam proses audit maupun investigasi. Untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut, penelitian ini mengacu pada keluarga kontrol *Audit and Accountability* (AU) pada NIST SP 800-53 Revision 5. Kontrol-kontrol tersebut dianalisis untuk menentukan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap komponen infrastruktur *audit trail* yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tidak seluruh kontrol pada keluarga AU dianalisis dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada kontrol yang memiliki keterkaitan langsung dengan perancangan infrastruktur *audit trail* pada DecMed. Hasil analisis kebutuhan keamanan berdasarkan kontrol NIST SP 800-53 Revision 5 ditunjukkan pada Tabel III.13.

Tabel III.13: Analisis Kebutuhan Infrastruktur Audit Trail berdasarkan NIST SP 800-53 Rev. 5

Kontrol	Nama Kontrol	Analisis	Kebutuhan Sistem
AU-2	Event Logging	Sistem harus menentukan aktivitas yang perlu dicatat sebagai audit trail berdasarkan kebutuhan organisasi dan risiko keamanan.	Sistem harus mampu mencatat seluruh audit event yang telah diidentifikasi pada tahap analisis audit event.

Kontrol	Nama Kontrol	Analisis	Kebutuhan Sistem
AU-3	Content of Audit Records	Setiap audit record harus memiliki informasi yang cukup untuk mendukung proses identifikasi dan investigasi suatu aktivitas.	Sistem harus menghasilkan audit record yang memiliki atribut lengkap seperti identitas pelaku, waktu kejadian, jenis aktivitas, objek yang diakses, dan hasil aktivitas.
AU-4	Audit Log Storage Capacity	Sistem harus menyediakan media penyimpanan yang memadai sehingga audit trail tetap tersedia selama periode retensi yang ditentukan.	Sistem harus menyediakan repositori audit yang mampu menyimpan audit trail sesuai kebutuhan retensi.
AU-5	Response to Audit Logging Process Failures	Kegagalan proses pencatatan audit harus dapat dideteksi dan ditangani agar tidak menyebabkan hilangnya audit trail.	Sistem harus mampu mendeteksi serta menangani kegagalan proses pencatatan audit.
AU-6	Audit Record Review, Analysis, and Reporting	Audit trail harus dapat ditinjau, dianalisis, dan disajikan untuk mendukung proses audit maupun investigasi.	Sistem harus menyediakan mekanisme pencarian, analisis, dan pelaporan audit trail.

Kontrol	Nama Kontrol	Analisis	Kebutuhan Sistem
AU-8	Time Stamps	Seluruh audit record harus menggunakan informasi waktu yang akurat dan konsisten.	Sistem harus memberikan timestamp yang konsisten pada setiap audit record.
AU-9	Protection of Audit Information	Audit trail harus terlindungi dari modifikasi maupun penghapusan yang tidak sah.	Sistem harus menjamin integritas dan perlindungan audit trail terhadap perubahan yang tidak sah.
AU-10	Non-repudiation	Audit trail harus mampu mendukung pembuktian bahwa suatu aktivitas benar-benar dilakukan oleh entitas tertentu.	Sistem harus mendukung non-repudiation melalui mekanisme yang menjaga keaslian audit record.
AU-11	Audit Record Retention	Audit trail harus dipertahankan selama periode yang telah ditentukan agar tetap tersedia untuk kebutuhan audit maupun investigasi.	Sistem harus menyediakan mekanisme retensi audit trail sesuai kebijakan penyimpanan.
AU-12	Audit Record Generation	Sistem harus secara otomatis menghasilkan audit record ketika audit event terjadi.	Sistem harus mampu menghasilkan audit record secara otomatis dari seluruh audit event yang telah ditentukan.

Kontrol	Nama Kontrol	Analisis	Kebutuhan Sistem
AU-13	Monitoring for Information Disclosure	Audit trail harus mendukung pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pengungkapan informasi yang tidak sah.	Sistem harus mendukung pemantauan audit trail untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
AU-14	Session Audit	Apabila diperlukan, sistem harus mampu menghubungkan audit trail dengan suatu sesi pengguna.	Sistem harus mendukung pencatatan informasi sesi untuk aktivitas yang memerlukan keterkaitan antar audit event.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel III.13, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan keamanan sistem *audit trail* tidak hanya berfokus pada kemampuan mencatat aktivitas, tetapi juga mencakup aspek integritas, ketersediaan, perlindungan, serta kemampuan audit trail dalam mendukung proses investigasi. Kontrol-kontrol tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen infrastruktur *audit trail* yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem *audit trail*. Kebutuhan tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan pada tahap perancangan arsitektur dan implementasi sistem yang diusulkan.

III.1.4.4 Ringkasan Kebutuhan Sistem Audit Trail

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, diperoleh kebutuhan sistem *audit trail* yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan sistem. Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi *audit event*, analisis komponen infrastruktur berdasarkan ISO 27789, analisis kesenjangan terhadap arsitektur DecMed, serta analisis kebutuhan keamanan berdasarkan

keluarga kontrol *Audit and Accountability* pada NIST SP 800-53 Revision 5.

Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem *audit trail*, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan karakteristik kualitas dan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem.

Tabel III.14: Kebutuhan Fungsional Sistem Audit Trail

ID	Kebutuhan
FR-01	Sistem harus mampu menerima seluruh <i>audit event</i> yang dihasilkan oleh komponen-komponen DecMed sesuai dengan daftar <i>audit event</i> yang telah ditentukan.
FR-02	Sistem harus secara otomatis membangkitkan <i>audit record</i> setiap kali terjadi <i>audit event</i> .
FR-03	Setiap <i>audit record</i> harus memiliki struktur dan atribut yang konsisten sesuai dengan skema audit yang telah ditentukan.
FR-04	Sistem harus menyimpan seluruh <i>audit record</i> pada repositori audit yang terdedikasi.
FR-05	Sistem harus menyediakan mekanisme untuk mengambil audit record berdasarkan parameter tertentu sebagai kebutuhan proses audit dan investigasi.
FR-06	Sistem harus mampu mendeteksi kegagalan pada proses pembangkitan maupun penyimpanan <i>audit record</i> .
FR-07	Sistem harus menyediakan mekanisme pengelolaan retensi <i>audit record</i> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Tabel III.15: Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Audit Trail

ID	Kebutuhan
NFR-01	Sistem harus menjamin integritas setiap <i>audit record</i> sehingga tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah.
NFR-02	Sistem harus menjamin keaslian (<i>authenticity</i>) setiap <i>audit record</i> .
NFR-03	Sistem harus memberikan <i>timestamp</i> yang akurat dan konsisten pada setiap <i>audit record</i> .

ID	Kebutuhan
NFR-04	Sistem harus menerapkan mekanisme <i>append-only</i> sehingga <i>audit record</i> yang telah tersimpan tidak dapat diubah ataupun dihapus.
NFR-05	Sistem harus mempertahankan <i>audit record</i> selama periode retensi yang ditentukan.
NFR-06	Sistem harus mendukung <i>non-repudiation</i> sehingga <i>audit record</i> dapat digunakan sebagai bukti bahwa suatu aktivitas benar-benar dilakukan oleh entitas yang tercatat.

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan menjadi acuan dalam tahap perancangan sistem *audit trail*. Pada tahap selanjutnya, setiap kebutuhan tersebut dipetakan ke dalam rancangan arsitektur, komponen, serta mekanisme implementasi yang sesuai dengan karakteristik arsitektur DecMed. Dengan demikian, rancangan sistem yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional pencatatan *audit trail*, tetapi juga memenuhi kebutuhan keamanan, integritas, dan akuntabilitas sebagaimana direkomendasikan oleh standar ISO 27789 dan NIST SP 800-53 Revision 5.

III.2 Rancangan

III.2.1 Arsitektur Sistem Audit Trail

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada Analisis Masalah penelitian ini mengusulkan penambahan satu komponen baru pada arsitektur DecMed, yaitu **Audit Trail Service (ATS)**. ATS dirancang sebagai layanan *backend* berbasis Rust dan *framework* Axum yang independen terhadap komponen DecMed yang telah ada (PRE Server, Gas Station Server, maupun *smart contract*), sehingga penambahan mekanisme audit trail tidak mengubah alur bisnis maupun fungsionalitas DecMed yang sudah berjalan.

ATS terdiri atas tiga komponen fungsional utama:

- **Audit Receiver** – menyediakan *endpoint* POST `/api/events` sebagai titik masuk tunggal seluruh audit *event* dari berbagai sumber pada sistem DecMed (Client Apps, PRE Server, Gas Station Server). Setiap *event* dikirimkan da-

lam format *signed payload* yang berisi tanda tangan digital Ed25519, memungkinkan ATS memverifikasi keaslian pengirim sebelum *event* diproses lebih lanjut.

- **Audit Logger** – menerima *event* yang telah diverifikasi dari Audit Receiver melalui antrian asinkron internal (*mpsc channel*), membentuk *audit record* dengan atribut standar, dan menerapkan mekanisme *hash-chaining* antar *record* sehingga setiap *record* menyimpan *prev_record_hash* dari *record* sebelumnya. Mekanisme ini menjamin bahwa modifikasi atau penghapusan satu *record* akan terdeteksi karena seluruh *record* sesudahnya akan memiliki nilai *record_hash* yang tidak konsisten.
- **Log Rotation & Archival Worker** – berjalan secara periodik dan bertanggung jawab atas tiga tahap pengarsipan: (i) merotasi berkas log aktif menjadi berkas arsip baru, (ii) mengunggah berkas arsip ke IPFS Cluster yang telah digunakan DecMed sebagai penyimpanan *off-chain*, sehingga menghasilkan *Content Identifier* (CID) sebagai penanda integritas berkas, dan (iii) menerbitkan metadata rotasi log ke jaringan IOTA melalui Gas Station Server yang telah ada, sebagai *trust anchor* yang *immutable*.

Dengan arsitektur tersebut, ATS tidak menambah infrastruktur penyimpanan baru, melainkan memanfaatkan kembali (*reuse*) infrastruktur *off-chain* (IPFS Cluster) dan *on-chain* (IOTA via Gas Station Server) yang sudah tersedia pada DecMed.

III.2.2 Mekanisme Pembangkitan dan Penerimaan Audit Event

Audit *event* dibangkitkan dari tiga sumber yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan, yaitu Client Apps, PRE Server, dan Gas Station Server. Setiap sumber mengirimkan *event* ke ATS dalam format *SignedEvent* yang terdiri atas tiga bidang:

- *payload* – representasi JSON dari *audit event* yang berisi seluruh atribut kontekstual aktivitas yang dicatat,
- *signature* – tanda tangan digital Ed25519 atas *payload* dalam representasi heksadesimal (64 byte), dan
- *public_key* – kunci publik Ed25519 pengirim dalam representasi heksade-

simal (32 byte).

Setelah diterima oleh Audit Receiver, ATS memverifikasi tanda tangan digital dengan menggunakan `public_key` yang disertakan, memastikan bahwa `payload` tidak mengalami perubahan sejak ditandatangani dan berasal dari entitas yang memiliki kunci privat yang bersesuaian. Apabila verifikasi berhasil, `payload` diurai menjadi objek `AuditEvent` yang diteruskan ke Audit Logger melalui antrian asinkron internal.

Setiap `AuditEvent` memuat atribut umum berikut yang wajib tersedia pada seluruh jenis *event*, mengacu pada kontrol AU-3 *Content of Audit Records* pada NIST SP 800-53 Rev. 5:

Tabel III.16: Atribut Umum Audit Event

Atribut	Deskripsi
<code>source_component</code>	Komponen sumber pembangkit <i>event</i> (mis. nama modul atau layanan).
<code>actor_id</code>	Identitas aktor yang memicu aktivitas, seperti <i>IOTA address</i> atau identitas sesi.
<code>target_object</code>	Identitas objek atau sumber daya yang menjadi target aktivitas.
<code>outcome</code>	Hasil pelaksanaan aktivitas: Success, Failure, Denied, atau Unknown.
<code>action_type</code>	Jenis tindakan yang dilakukan.
<code>event_type</code>	Jenis <i>audit event</i> yang merujuk pada katalog <i>event</i> (EV1–EV18) beserta atribut tambahan yang spesifik terhadap jenis tersebut.

Atribut `event_type` diimplementasikan sebagai *tagged enum* (`AuditEventDetails`) yang memuat atribut tambahan spesifik sesuai jenis *event*, sebagaimana telah diidentifikasi pada Tabel III.9.

III.2.3 Mekanisme Pembentukan dan Penyimpanan Audit Record

Setelah *event* diterima dari antrian internal, Audit Logger membentuk sebuah `AuditRecord` yang terdiri atas:

- `record_id` – pengenal unik berbasis UUID v7 yang mengandung informasi waktu sehingga bersifat monoton dan dapat diurutkan secara kronologis,
- `timestamp` – waktu pembentukan *record* dalam format UTC,

- `prev_record_hash` – nilai *hash* SHA-256 dari *record* sebelumnya, atau `null` apabila merupakan *record* pertama dalam rantai,
- `record_hash` – nilai *hash* SHA-256 dari kombinasi `record_id`, `timestamp`, `prev_record_hash`, dan isi *event*, serta
- seluruh atribut `AuditEvent` yang telah diverifikasi.

Mekanisme `record_hash` yang menyertakan `prev_record_hash` membentuk rantai *hash* (*hash chain*) antar *record* yang bersifat *append-only*: penambahan, modifikasi, atau penghapusan *record* pada posisi mana pun dalam rantai akan menyebabkan nilai `record_hash` seluruh *record* sesudahnya menjadi tidak konsisten, sehingga kerusakan dapat terdeteksi. Setiap `AuditRecord` yang terbentuk kemudian ditulis secara *append* ke berkas log lokal dalam format JSON-Lines (satu objek JSON per baris), menjamin bahwa berkas log tidak pernah menimpa entri yang sudah ada.

III.2.4 Mekanisme Rotasi, Pengarsipan, dan Publikasi Metadata

Log Rotation & Archival Worker berjalan secara periodik pada interval yang dapat dikonfigurasi. Pada setiap siklus rotasi, worker melakukan tiga tahap berurutan:

Tahap 1 – Rotasi berkas log. Worker mengganti nama berkas log aktif dengan nama berkas arsip baru yang menyertakan *timestamp* rotasi. Operasi penggantian nama ini bersifat atomik pada sistem berkas sehingga tidak terjadi kehilangan *record* yang sedang ditulis.

Tahap 2 – Pengarsipan ke IPFS. Worker menghitung nilai *hash* SHA-256 dari berkas arsip sebagai *fingerprint* integritas berkas, kemudian mengunggah berkas tersebut ke IPFS Cluster melalui endpoint `/add`. Proses unggah menghasilkan CID yang bersifat unik terhadap isi berkas; apabila isi berkas berubah, CID yang dihasilkan juga akan berbeda.

Tahap 3 – Publikasi metadata ke IOTA. Worker menyusun objek `IotaLogMetadata` yang memuat informasi rotasi, termasuk CID hasil unggah IPFS, nilai *hash* berkas, nomor urut rotasi (`log_sequence_number`), waktu rotasi, dan referensi *transaction digest* rotasi sebelumnya (`prev_tx_digest`) untuk membentuk rantai antar entri metadata *on-chain*. Metadata tersebut kemudian diterbitkan ke jaringan IOTA me-

lalui Gas Station Server yang telah ada, menghasilkan *transaction digest* baru yang bersifat *immutable*.

Kombinasi CID (di IPFS) dan *transaction digest* (di IOTA) memberikan dua lapis jaminan bagi setiap berkas arsip log: isi berkas tidak dapat diubah tanpa mengubah CID-nya, dan CID beserta metadata yang telah diterbitkan ke IOTA tidak dapat diubah maupun dihapus setelah transaksi final. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat memverifikasi keutuhan suatu berkas arsip log secara independen dengan mengambil metadata dari IOTA, mengambil berkas dari IPFS menggunakan CID yang tercatat, menghitung ulang nilai *hash* SHA-256 berkas, dan membandingkannya dengan nilai *file_hash* yang tersimpan pada metadata IOTA.

III.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Sistem

Tabel III.17 menunjukkan pemetaan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan pada Tabel III.14 dan Tabel III.15 dengan mekanisme implementasi pada ATS yang dirancang.

Tabel III.17: Pemetaan Kebutuhan ke Mekanisme Rancangan ATS

ID	Kebutuhan	Mekanisme pada ATS
FR-01	Menerima seluruh audit event sesuai katalog.	Endpoint POST <code>/api/events</code> menerima seluruh jenis event EV1–EV18 melalui format <code>SignedEvent</code> yang seragam.
FR-02	Membangkitkan audit record secara otomatis.	Audit Logger membentuk <code>AuditRecord</code> secara otomatis untuk setiap event yang diterima dari antrian internal.
FR-03	Struktur dan atribut audit record yang konsisten.	Seluruh <i>record</i> mengikuti skema <code>AuditRecord</code> yang seragam dengan atribut wajib dan <i>tagged enum</i> untuk atribut tambahan.

ID	Kebutuhan	Mekanisme pada ATS
FR-04	Menyimpan audit record pada repositori terdedikasi.	Record ditulis ke berkas log lokal (JSON-Lines), lalu diarsipkan ke IPFS dengan referensi metadata di IOTA.
FR-05	Mengambil audit record untuk proses audit dan investigasi.	Metadata rotasi yang tersimpan di IOTA menyediakan CID untuk mengambil berkas arsip lengkap dari IPFS.
FR-06	Mendeteksi kegagalan proses pembangkitan dan penyimpanan.	Kegagalan pada setiap tahap (verifikasi, penulisan, unggah IPFS, publikasi IOTA) dicatat ke <i>stderr</i> dan siklus rotasi dilanjutkan pada interval berikutnya.
FR-07	Pengelolaan retensi audit record.	Berkas arsip yang telah diunggah ke IPFS dihapus dari penyimpanan lokal sementara. Retensi jangka panjang bergantung pada kebijakan <i>pinning</i> pada IPFS Cluster.
NFR-01	Integritas setiap audit record.	Mekanisme <i>hash-chaining</i> (<i>record_hash</i> yang menyertakan <i>prev_record_hash</i>) menjamin deteksi modifikasi.
NFR-02	Keaslian (<i>authenticity</i>) audit record.	Verifikasi tanda tangan digital Ed25519 atas setiap <i>payload</i> event sebelum <i>record</i> dibentuk.
NFR-03	Timestamp yang akurat dan konsisten.	Setiap <i>record</i> menggunakan <i>Utc::now()</i> pada saat pembentukan <i>record</i> oleh Audit Logger.

ID	Kebutuhan	Mekanisme pada ATS
NFR-04	Mekanisme <i>append-only</i> .	Penulisan ke berkas log menggunakan mode <i>append</i> ; mekanisme <i>hash-chaining</i> membuat modifikasi entri lama terdeteksi.
NFR-05	Retensi audit record.	Arsip log disimpan secara permanen di IPFS (dengan <i>pinning</i>) dan referensinya tercatat secara <i>immutable</i> di IOTA.
NFR-06	Dukungan <i>non-repudiation</i> .	Tanda tangan digital Ed25519 pada setiap <i>event</i> membuktikan bahwa <i>payload</i> dibuat oleh entitas yang memiliki kunci privat bersesuaian, dan <i>hash-chaining</i> membuktikan urutan kejadian tidak dapat diubah.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan proses implementasi dari rancangan solusi yang telah dipaparkan pada Bab III, khususnya penambahan layanan *Audit Trail Service* (ATS) dan integrasinya ke dalam arsitektur sistem DecMed yang telah ada.

IV.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi dilakukan pada lingkungan yang sama dengan yang digunakan pada penelitian DecMed sebelumnya, sebagaimana dijelaskan pada Subbab I.4. Komponen ATS berjalan sebagai layanan *backend* Rust yang berdiri sendiri di lingkungan lokal bersama PRE Server. Daftar dependensi utama yang digunakan pada implementasi ATS ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1: Dependensi Utama Audit Trail Service

Dependensi	Versi	Fungsi
axum	0.8.4	<i>Web framework</i> HTTP untuk endpoint penerimaan <i>audit event</i> .
tokio	1.44.2	<i>Async runtime</i> Rust untuk pemrosesan konkuren.
serde / serde_json	1.x	Serialisasi dan deserialisasi data JSON.
ed25519-dalek	3.0.0	Verifikasi tanda tangan digital Ed25519 pada <i>signed event</i> .
sha2	0.10	Komputasi <i>hash</i> SHA-256 untuk mekanisme <i>hash-chaining</i> .
uuid	1.x	Pembangkitan <i>record_id</i> berbasis UUID v7 yang bersifat monoton.
chrono	0.4.39	Penanganan waktu dan <i>timestamp</i> dalam format UTC.
iota-sdk	1.2.0-alpha	Interaksi dengan jaringan IOTA untuk publikasi metadata rotasi log.
reqwest	0.12	Klien HTTP untuk unggah berkas ke IPFS dan interaksi dengan Gas Station.
tokio-util	0.7.11	<i>Streaming</i> berkas saat unggah ke IPFS menggunakan <i>BytesCodec</i> .

Pada PRE Server yang telah ada, dependensi *ed25519-dalek* versi 2.x ditambahk-

an untuk mendukung pembangkitan pasangan kunci penandatanganan event pada sisi pengirim.

IV.2 Implementasi

Implementasi sistem audit trail pada penelitian ini terdiri atas dua bagian utama. Pertama, implementasi komponen-komponen internal ATS sebagai layanan *backend* yang berdiri sendiri. Kedua, implementasi integrasi ATS ke dalam PRE Server yang telah ada pada arsitektur DecMed. Daftar komponen yang diimplementasikan beserta keterkaitan dengan rancangan ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2: Daftar Implementasi Sistem Audit Trail

ID	Komponen	Merealisasikan Rancangan
I-ATS-01	Skema tipe data AuditEvent dan AuditRecord.	Katalog <i>audit event</i> (EV1–EV18) dan skema atribut audit pada Tabel III.8–III.9.
I-ATS-02	Endpoint POST /api/events dan mekanisme verifikasi <i>signed event</i> .	Komponen Audit Receiver pada rancangan ATS.
I-ATS-03	Komponen AuditLogger dengan antrian asinkron internal.	Komponen Audit Logger dengan mekanisme <i>hash-chaining</i> .
I-ATS-04	Worker rotasi log, unggah IPFS, dan publikasi metadata ke IOTA.	Komponen Log Rotation & Archival Worker.
I-ATS-05	Modul ats pada PRE Server dan ATSCient.	Integrasi ATS ke dalam arsitektur DecMed.

IV.2.1 Implementasi Skema Tipe Data Audit

Implementasi skema tipe data audit merealisasikan katalog *audit event* dan skema atribut yang telah ditentukan pada Subbab ???. Seluruh tipe data didefinisikan pada berkas `audit-trail/src/types.rs`.

Tipe data AuditEvent mewakili satu peristiwa audit yang diterima dari komponen pengirim. Tipe ini memuat atribut umum yang wajib ada pada seluruh jenis *event* serta atribut tambahan yang spesifik terhadap jenis *event* melalui mekanisme *tagged enum* AuditEventDetails. Pendekatan ini memungkinkan satu struktur

data tunggal merepresentasikan seluruh 18 jenis *event* (EV1–EV18) yang telah diidentifikasi, dengan validasi tipe yang dijalankan oleh *compiler* Rust pada waktu kompilasi.

AuditEventDetails diimplementasikan sebagai *tagged enum* dengan anotasi `#[serde(tag = "event_type")]` sehingga nilai `event_type` pada JSON yang masuk menentukan varian enum yang akan diparsing. Setiap varian memuat atribut tambahan yang spesifik terhadap jenis *event* sesuai Tabel III.9. Sebagai contoh, varian EV6 untuk *event* permintaan layanan PRE memuat atribut `endpoint_called`, `request_id`, `caller_component`, dan `channel_encryption`.

Tipe data AuditRecord mewakili catatan audit yang telah terbentuk dan siap disimpan. Tipe ini memuat `record_id` berbasis UUID v7, `timestamp` dalam format UTC, `prev_record_hash` untuk membentuk rantai *hash*, `record_hash` sebagai sidik jari *record*, serta seluruh atribut AuditEvent melalui mekanisme `#[serde(flatten)]`. Penggunaan `flatten` memastikan seluruh atribut *event* diserialisasi pada tingkat yang sama dengan atribut *record* sehingga berkas JSON-Lines yang dihasilkan mudah dibaca.

Tipe data SignedEvent mewakili struktur yang diterima dari komponen pengirim melalui endpoint HTTP. Tipe ini memuat tiga bidang: *payload* sebagai representasi JSON dari *audit event*, *signature* sebagai tanda tangan digital Ed25519 atas *payload* dalam representasi heksadesimal, dan *public_key* sebagai kunci publik pengirim dalam representasi heksadesimal.

AuditOutcome diimplementasikan sebagai enum dengan empat varian: *Success*, *Failure*, *Denied*, dan *Unknown*, merealisasikan atribut *outcome* pada skema atribut umum Tabel III.8.

IV.2.2 Implementasi Audit Receiver

Komponen Audit Receiver diimplementasikan melalui handler `handle_event` pada berkas `audit-trail/src/handlers.rs` dan *routing* pada `audit-trail/src/main.rs`. Endpoint `POST /api/events` menerima *request* berisi objek SignedEvent dalam format JSON.

Proses pada handler `handle_event` terdiri atas dua fase. Fase pertama adalah verifikasi sumber *event* melalui fungsi `Utils::verify_and_extract_event`. Fungsi

ini melakukan tiga langkah: mendekode kunci publik dari representasi heksadesimal menjadi `VerifyingKey Ed25519`, mendekode tanda tangan dari representasi heksadesimal menjadi `Signature Ed25519`, kemudian memverifikasi tanda tangan terhadap byte-byte *payload*. Apabila verifikasi berhasil, *payload* string diurai menjadi objek `AuditEvent`. Apabila verifikasi gagal, handler mengembalikan respons *error* tanpa memproses *event* lebih lanjut.

Fase kedua adalah memasukkan *event* yang telah terverifikasi ke dalam antrian asinkron internal melalui `state.audit_tx.send(audit_event).await`. Antrian ini diimplementasikan menggunakan `tokio::sync::mpsc` dengan kapasitas 10.000 *event*, memastikan ATS dapat menerima *event* dalam jumlah besar tanpa memblokir pengirim.

Struktur `Handlers` hanya menyimpan `audit_tx` bertipe `Sender<AuditEvent>` sebagai satu-satunya *state*. Desain ini dengan sengaja memisahkan proses penerimaan *event* dari proses pembentukan dan penyimpanan *audit record*, sehingga keduanya dapat berjalan secara konkuren tanpa saling memblokir.

IV.2.3 Implementasi Audit Logger

Komponen Audit Logger diimplementasikan sebagai struct `AuditLogger` pada berkas `audit-trail/src/audit.rs`. Komponen ini berjalan sebagai *task* Tokio terpisah yang di-*spawn* pada saat aplikasi dimulai, menerima *event* dari antrian asinkron, membentuk *audit record*, dan menulis ke berkas log.

`AuditLogger` menyimpan dua bidang: `rx` bertipe `Receiver<AuditEvent>` sebagai sisi penerima antrian asinkron, dan `prev_record_hash` bertipe `Option<String>` sebagai hash dari *record* sebelumnya untuk keperluan *hash-chaining*. Bidang `prev_record_hash` diinisialisasi dengan `None` pada *record* pertama dalam satu siklus kerja ATS.

Metode `run` menjalankan *loop* utama yang terus berjalan selama pengirim masih aktif, menggunakan pola `while let Some(event) = self.rx.recv().await`. Untuk setiap *event* yang diterima, *loop* melakukan tiga langkah berurutan. Pertama, memanggil fungsi `create_audit_record` untuk membentuk `AuditRecord` baru. Kedua, memanggil fungsi `write_audit_record` untuk menulis *record* ke berkas log. Ketiga, memperbarui `self.prev_record_hash` dengan *hash* dari *record* yang baru saja ditulis.

Fungsi `create_audit_record` merealisasikan mekanisme *hash-chaining* dengan langkah-langkah berikut: membangkitkan `record_id` baru menggunakan `Uuid::now_v7()`, mengambil waktu saat ini menggunakan `Utc::now()`, kemudian mendelegasikan komputasi *hash* ke `Utils::calculate_record_hash`. Fungsi `calculate_record_hash` menggabungkan `record_id`, `timestamp`, `prev_record_hash`, dan isi *event* menjadi satu objek JSON, kemudian menghitung SHA-256 dari representasi JSON tersebut dan mengembalikannya sebagai string heksadesimal.

Fungsi `write_audit_record` membuka berkas log dengan mode *append* menggunakan `OpenOptions::new().create(true).append(true)`, kemudian menulis representasi JSON dari *record* diikuti karakter baris baru (`\n`). Penggunaan mode *append* menjamin bahwa entri yang sudah ada tidak pernah tertimpa, merealisasikan karakteristik *append-only* yang disyaratkan oleh NFR-04. Konstanta `LOG_FILE_PATH` yang merujuk ke `./logs/audit_logs.log` didefinisikan pada `audit-trail/src/c` dan digunakan sebagai satu-satunya referensi jalur berkas log di seluruh kode ATS.

IV.2.4 Implementasi Log Rotation dan Archival Worker

Komponen Log Rotation & Archival Worker diimplementasikan sebagai fungsi `Utils::spawn_log_rotation_worker` pada berkas `audit-trail/src/Utils.rs`. Fungsi ini menerima satu argumen `package_id` yang merupakan ID paket *smart contract* ATS pada jaringan IOTA, kemudian men-*spawn* sebuah *task* Tokio yang berjalan selamanya dengan interval yang dapat dikonfigurasi melalui konstanta `LOG_ROTATION_INTERVAL`. Setiap siklus rotasi, worker melakukan tiga tahap berurutan.

Tahap 1 – Rotasi berkas log. Worker memeriksa apakah berkas log aktif ada dan tidak kosong. Apabila berkas kosong, siklus dilewati. Apabila berkas berisi data, worker membentuk nama berkas arsip baru dengan format `logs/uploading-{timestamp}.log` menggunakan *Unix timestamp* saat ini, kemudian memindahkan berkas log aktif ke nama arsip baru menggunakan `fs::rename`. Operasi `rename` bersifat atomik pada sistem berkas Linux sehingga tidak terjadi kehilangan *record* yang sedang ditulis oleh Audit Logger.

Tahap 2 – Unggah ke IPFS. Worker menghitung nilai *hash* SHA-256 dari berkas arsip menggunakan `IotaLogClient::hash_file`, kemudian mengunggah berkas ke IPFS Cluster melalui fungsi `Utils::add_file_to_ipfs`. Fungsi ini menggu-

nakan FramedRead dengan BytesCodec untuk melakukan *streaming* berkas tanpa memuat seluruh konten ke memori sekaligus, yang penting untuk berkas log berukuran besar. Respons dari IPFS menghasilkan CID yang menjadi penanda konten berkas.

Tahap 3 – Publikasi metadata ke IOTA. Worker membentuk objek `IotaLogMetadata` yang memuat informasi rotasi, termasuk CID hasil unggah IPFS, nilai *hash* berkas (`file_hash`), nomor urut rotasi (`log_sequence_number`), waktu rotasi, dan referensi *transaction digest* rotasi sebelumnya (`prev_tx_digest`). Bidang `prev_tx_digest` membentuk rantai antar entri metadata *on-chain*, analog dengan mekanisme *hash-chaining* pada *audit record*. Metadata tersebut kemudian diterbitkan ke jaringan IOTA melalui `IotaLogClient::publish_metadata`.

Implementasi `IotaLogClient` pada berkas `audit-trail/src/iota_client.rs` menangani seluruh interaksi dengan jaringan IOTA. Fungsi `publish_metadata` melakukan serangkaian langkah: menserialisasi metadata ke JSON string, membangun transaksi IOTA menggunakan `ProgrammableTransactionBuilder`, mem-reservasi *gas* dari Gas Station Server, menandatangani transaksi dengan kunci privat ATS, kemudian mengeksekusi transaksi melalui Gas Station Server. Apabila transaksi berhasil, fungsi mengembalikan `PublishResult` yang memuat `object_id` objek `LogRecord` yang dibuat *on-chain* serta `tx_digest` transaksi.

Smart contract Move yang digunakan ATS didefinisikan pada `move/ats/sources/audit_trail.mo`. Modul `ats::audit_log` menyediakan fungsi `create_log` yang menerima string JSON metadata kemudian membuat objek `LogRecord` yang di-*freeze* sehingga bersifat *immutable* setelah dibuat. Pembekuan objek (`transfer::freeze_object`) adalah mekanisme utama yang menjamin sifat *immutability* metadata rotasi log pada jaringan IOTA, merealisasikan NFR-01 dan NFR-05.

Setelah publikasi ke IOTA berhasil, worker memperbarui `prev_tx_digest` untuk siklus berikutnya dan menghapus berkas arsip dari penyimpanan lokal menggunakan `fs::remove_file`. Retensi jangka panjang bergantung pada mekanisme *pinning* IPFS Cluster yang telah digunakan DecMed.

IV.2.5 Implementasi Integrasi ATS pada PRE Server

Integrasi ATS ke dalam PRE Server yang telah ada diimplementasikan melalui penambahan modul `ats` pada direktori `proxy-reencryption/src/ats/`. Modul ini terdiri atas dua berkas: `ats.rs` yang memuat implementasi utama dan `mod.rs` yang mengekspos tipe-tipe publik.

Tipe data bersama. Berkas `ats.rs` mendefinisikan ulang tipe-tipe data `AuditEvent`, `AuditOutcome`, dan `AuditEventDetails` yang strukturnya setara dengan yang ada di ATS. Pendekatan ini dipilih agar PRE Server tidak bergantung pada *create* ATS secara langsung, mempertahankan independensi antarkomponen. Varian `AuditEventDetails` yang diimplementasikan pada PRE Server mencakup jenis *event* yang relevan dengan operasi PRE: EV6 untuk permintaan layanan PRE, EV7 untuk operasi *re-encryption*, EV13 untuk penulisan Redis, EV14 untuk pembacaan Redis, dan EV15 untuk operasi IPFS. Tipe `SignedAuditEvent` mendefinisikan struktur JSON yang akan dikirimkan ke endpoint `POST /api/events` pada ATS.

Implementasi ATSCClient. Struct `ATSCClient` bertanggung jawab mengelola pasangan kunci Ed25519 untuk penandatanganan *event* serta mengirimkan *signed event* ke ATS. Kunci Ed25519 dibangkitkan secara acak pada saat inisialisasi menggunakan `SigningKey::generate(&mut OsRng)`, sehingga setiap instans PRE Server memiliki kunci penandatanganan yang unik. Kunci publik yang bersesuaian disertakan pada setiap *signed event* agar ATS dapat memverifikasi tanda tangan tanpa perlu menyimpan daftar kunci yang diizinkan.

`ATSCClient` menyediakan dua metode pengiriman. Metode `send_event` bersifat *async* dan menunggu respons dari ATS, berguna ketika kode pemanggil perlu menangani *error* pengiriman. Metode `send_event_nonblocking` men-*spawn task* Tokio terpisah yang berjalan secara *fire-and-forget*; apabila pengiriman gagal, *error* hanya dicatat ke `stderr` tanpa memblokir alur utama. Metode kedua inilah yang digunakan di seluruh handler PRE Server agar operasi audit tidak menambah latensi pada alur layanan utama.

Implementasi `ATSWorker` sebagai *helper* internal menangani proses penandatanganan dan pengiriman pada *spawned task*. Worker ini menyalin byte-byte kunci penandatanganan dari `ATSCClient` agar dapat merekonstruksi `SigningKey` di dalam task yang bersifat *'static*. Proses penandatanganan menggunakan `self.signing_key.sign(&payload`

dari *trait* `Signer` pada *crate* `ed25519-dalek`, menghasilkan tanda tangan 64-byte yang kemudian dikodekan sebagai heksadesimal.

Integrasi ke AppState. Bidang `ats_client`: `ATSClient` ditambahkan pada `struct AppState` di `proxy-reencryption/src/types.rs`. Inisialisasi dilakukan pada `main.rs` dengan membaca `ATS_ENDPOINT` dari *environment variable*, kemudian memanggil `ATSClient::with_endpoint(&ats_endpoint)`. Nilai *default* endpoint adalah `http://localhost:3000/api/events` apabila variabel tidak dikonfigurasi.

Instrumentasi handler. Tiga handler PRE Server diinstrumentasi untuk mengirimkan *audit event*:

1. Handler `get_nonce_handler` mengirimkan *event* EV6 (`PRERequest`) setelah *nonce* berhasil disimpan di Redis, mencatat endpoint yang dipanggil, ID permintaan, komponen pemanggil, dan status enkripsi kanal.
2. Handler `store_keys` mengirimkan *event* EV13 (`RedisWrite`) setelah kunci PRE berhasil disimpan di Redis, mencatat jenis kunci Redis, jenis operasi, dan TTL yang tersisa dalam detik.
3. Handler `create_medical_record` mengirimkan *event* EV15 (`IPFSOperation`) setelah data terenkripsi berhasil diunggah ke IPFS, mencatat CID yang dihasilkan, jenis operasi, dan ukuran data.

Seluruh instrumentasi menggunakan metode `send_event_nonblocking` agar tidak menambah latensi pada alur utama. Variabel *environment* `ATS_ENDPOINT` pada berkas `proxy-reencryption/.env` dikonfigurasi ke `http://localhost:3000/api/events` agar PRE Server mengirimkan event ke instans ATS yang berjalan di lingkungan lokal.

IV.2.6 Implementasi Verifikasi Integritas Audit Record

Fungsi `Utils::verify_record` pada berkas `audit-trail/src/utils.rs` merealisasikan mekanisme verifikasi integritas satu *audit record*. Fungsi ini menghitung ulang `record_hash` dari `record_id`, `timestamp`, `prev_record_hash`, dan isi *event* menggunakan `calculate_record_hash`, kemudian membandingkannya dengan `record_hash` yang tersimpan. Kesamaan nilai keduanya membuktikan bahwa

record tidak mengalami modifikasi sejak dibuat.

Verifikasi rantai secara penuh dilakukan dengan memeriksa setiap *record* secara berurutan: nilai *prev_record_hash* setiap *record* harus sama persis dengan *record_hash* dari *record* sebelumnya. Apabila terdapat *record* yang dihapus, ditambahkan, atau dimodifikasi di tengah rantai, nilai *record_hash* seluruh *record* sesudahnya akan menjadi tidak konsisten dan verifikasi akan gagal.

IV.3 Pengujian

[Bagian pengujian akan ditambahkan setelah implementasi selesai diverifikasi.]

IV.4 Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

V.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M., Shah, R., Tummala, H., & Ray, I. (2025). Did You Break the Glass Properly? A Policy Compliance Framework for Protected Health Information (PHI) Emergency Access. *Proceedings of the 22nd International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2025)*, 195–208.
- Benet, J. (2014). IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System. <https://arxiv.org/abs/1407.3561>
- Hernández-Ramos, J. L., Jara, A. J., Marin, L., & Skarmeta, A. F. (2013). Distributed Capability-Based Access Control for the Internet of Things. *Journal of Internet Services and Information Security (JISIS)*, 3(3/4), 1–16.
- International Organization for Standardization. (2021). ISO 27789:2021 – Health Informatics – Audit Trails for Electronic Health Records (Second edition). <https://www.iso.org/standard/76028.html>
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27002:2022 – Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection – Information Security Controls [Control 8.15: Logging]. <https://www.iso.org/standard/75652.html>
- Islam, M. S., & Rahman, M. S. (2025). LogStamping: A Blockchain-Based Log Auditing Approach for Large-Scale Systems. <https://arxiv.org/abs/2505.17236>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>
- Laksono, A. C., & Prayudi, Y. (2021). Threat Modeling Menggunakan Pendekatan STRIDE dan DREAD untuk Mengetahui Risiko dan Mitigasi Keamanan pada Sistem Informasi Akademik. *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)*, 6(1), 9–20. <https://doi.org/10.32528/justindo.v6i1.3944>
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations* (techreport **number** NIST

- Special Publication 800-53, Revision 5). U.S. Department of Commerce.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Pramesti, D. P. A., Ayuningtyas, D., & Verdi, R. (2024). Keamanan dan Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tinjauan Sistematis. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 7691–7702. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.38445>
- Purnama, H., Sudewa, I. P. B. H., Nizami, T., Rosyada, B. S., Mahesa, P. R., & Ahmadi, N. (2026). Access Control Development Within the Framework of an IOTA-Based Electronic Medical Record Management System. *Sensors*, 26(5), 1422.
- Theis, M., Trzeciak, R. F., Costa, D. L., Moore, A. P., Miller, S., Cassidy, T., & Clancycomb, W. R. (2022). *Common Sense Guide to Mitigating Insider Threats* (techreport) (7th edition). CERT Division, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Lampiran A. Contoh gambar pengujian



Gambar A.1: Contoh gambar